



NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43
E-mail: editorial@grupocto.com
Página web: www.grupocto.com



Cirugía General

Un paciente con dolor epigástrico irradiado en cinturón y elevación de amilasa 3 veces por encima del valor de referencia acude a las urgencias hospitalarias. Respecto a la enfermedad que sospecha, señale la respuesta falsa:

1. Es conveniente realizar TC abdominal a todos los pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda para descartar complicaciones
2. La pancreatitis se clasifican como leves o graves en función de la necrosis y el fallo orgánico (respiratorio , cardiovascular y renal)
3. Los pacientes con pancreatitis leve no precisan tratamiento antibiótico. Es recomendable practicar la colecistectomía durante el mismo ingreso tras la resolución del cuadro de pancreatitis aguda litiasica
4. Dentro de las indicaciones quirúrgicas para la pancreatitis aguda se incluye la perforación de víscera hueca .

Resp. Correcta: 1

Comentario: No está estandarizado la realización de TC abdominal a cualquier paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda. Éste se reserva para aquellos casos con riesgo de complicación.

-----O-----
¿Como denominamos a un tumor de recto que sobrepasa la muscular entrando en la grasa del mesorrecto y tiene una adenopatía metastásica peritumoral?

1. T2 N1
2. T3 N1
3. T3 N2
4. T4 N1

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Es importante que recuerdes el TNM del cáncer colorrectal:

Tis: sólo mucosa

T1 afectación submucosa

T2 llega a la muscular

T3 afecta a la subserosa en el colon y a la grasa de mesorrecto en el recto.

T4 afecta a órganos vecinos. Los tumores perforados se consideran T4

-----O-----
Paciente varón de 65 años intervenido por un early cáncer en antro gástrico hace 7 meses. Se practicó una antrectomía con reconstrucción Bilroth II. Consulta porque tras las comidas, a la media hora, presenta sensación nauseosa, mareos, sudoración que suelen ir acompañados de despeños diarreicos. Ante esta sintomatología, usted

sospecha:

1. Un síndrome de asa aferente.
2. Un síndrome de asa eferente.
3. Un reflujo alcalino.
4. Un síndrome de dumping precoz.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La complicación que se presenta corresponde a un síndrome de dumping tras gastrectomía. Este síndrome se caracteriza por un conjunto de molestias posprandiales causadas por el vaciamiento gástrico rápido en el intestino como consecuencia de la falta de regulación pilórica. Se distinguen dos tipos de dumping: precoz y tardío, cuya fisiopatología es diferente. El dumping precoz, que es el del caso expuesto, es más frecuente que el tardío y ocurre en los 15-30 minutos que siguen a la ingesta, provocado por el paso rápido de contenido hiperosmolar al yeyuno que ocasiona un desplazamiento brusco de líquido del espacio vascular y la consecuente disminución del volumen plasmático con aparición de taquicardia y disminución de la presión arterial.

Indique la correcta respecto a la enfermedad diverticular colónica:

1. La localización más frecuente de los divertículos es el colon ascendente.
2. La prevalencia de diverticulosis disminuye con la edad.
3. La dieta pobre en fibra previene su aparición.
4. En la mayoría de los casos de diverticulosis el tratamiento no es necesario .

Resp. Correcta: 4

Comentario: Los divertículos pueden aparecer en cualquier segmento colónico, pero son más frecuentes en el lado izquierdo, fundamentalmente, el sigma. La prevalencia de diverticulosis aumenta con la edad, siendo muy baja en jóvenes y llegando al 80% a partir de la séptima década. La ingesta de abundante fibra aumenta el bolo fecal, disminuye la presión intracólica y acelera el tránsito intestinal, lo que se considera un factor determinante para prevenir la aparición de divertículos colónicos. La mayoría de los pacientes con diverticulosis no presenta síntomas y el diagnóstico suele ser un hallazgo incidental; La clínica es inespecífica y caracterizada por dolor abdominal cólico, moderada distensión abdominal, anorexia, flatulencia y alteración del ritmo deposicional. El tratamiento en la mayoría de los casos no es necesario (respuesta 4) recomendándose solo medidas dietéticas. Si no es suficiente algunos probióticos, o fármacos como la rifaximina pueden mejorar la sintomatología.

La causa MÁS frecuente de perforación esofágica es:

1. Tumoral.
2. Postemética.
3. Iatrogénica.
4. Ingestión cuerpos extraños.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La mayoría de las perforaciones esofágicas son iatrogénicas (respuesta 3 correcta) debido a la gran cantidad

de procedimientos diagnósticoterapéuticos que se realizan por vía endoscópica en la actualidad. Las demás causas traumáticas, posteméticas o espontáneas son más infrecuentes y requieren un alto índice de sospecha.

¿Cuál de las siguientes NO es indicación quirúrgica en la pancreatitis crónica?:

1. Ictericia obstructiva.
2. Dolor intratable.
3. Dificultad de vaciado gástrico.
4. Persistencia de esteatorrea a pesar del tratamiento médico.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El tratamiento de la pancreatitis crónica es fundamentalmente médico. Las principales indicaciones de tratamiento quirúrgico son: 1) Dolor persistente e incontrolable. 2) Ictericia obstructiva. 3) No poder descartar un cáncer subyacente y 4) Complicaciones. De todas las indicaciones la presencia de dolor no controlable con analgésicos es la indicación más frecuente. El dolor generalmente se debe a la existencia de un conducto de Wirsung mal drenado (por obstrucción o estenosis) y la técnica quirúrgica a emplear dependerá del calibre del conducto de Wirsung, de la localización de la zona estenótica, etc. Entre las posibles complicaciones que pueden precisar intervención estarían las derivadas de la existencia de un pseudoquistes que puede condicionar una obstrucción al vaciamiento gástrico por compresión, etc. o las derivadas de la rotura del conducto pancreático que dan lugar a la aparición de ascitis pancreática o derrame pleural pancreático.

La complicación potencialmente quirúrgica más frecuente de la pancreatitis aguda es:

1. Shock hemodinámico.
2. Septicemia.
3. Pseudoquistes.
4. Absceso pancreático.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Desde el punto de vista quirúrgico la complicación más frecuente de la pancreatitis aguda es la formación de un pseudoquistes pancreático, lo cual sucede hasta en el 15 % de los casos (entre el 2 y 10 % en la mayor parte de las series). La formación de un absceso pancreático es otra posible complicación que se produce por la infección de un pseudoquistes o en el contexto de una pancreatitis necrotizante con una frecuencia alrededor del 5 % de los casos. Hay que tener en cuenta que existen "complicaciones médicas" en el curso de la pancreatitis que pueden ser mucho más frecuentes que las comentadas. Así se han publicado que los pacientes con pancreatitis aguda tiene algún grado de disfunción pulmonar hasta en el 70 % de los casos manifestada como una hipoxemia transitoria, requiriendo ventilación mecánica en menos del 5 % de los casos. También hasta el 50 % de los pacientes tienen signos clínicos de mala perfusión tisular y diferentes grados de disfunción renal son demostrables entre el 40 - 80 % de los pacientes con una incidencia de insuficiencia renal aguda entre el 2 y 20 % de los casos.

En una mujer que tras la extracción endoscópica de un cuerpo extraño impactado en el tercio medio esofágico presenta dolor retroesternal, dificultad respiratoria y

crepitación cervical, se realiza un estudio radiológico esofagográfico con contraste hidrosoluble, encontrando fuga del contraste a nivel del esófago torácico. En este caso, ¿cuál es la complicación más grave que puede presentarse?:

1. Mediastinitis.
2. Fístula esofágica.
3. Estenosis esofágica.
4. Derrame pleural bilateral.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La complicación de un cuerpo extraño impactado en esófago es la perforación y, como consecuencia de la misma, la mediastinitis y el neumomediastino con crepitación cervical. Raramente se observan fístulas esofágicas que comunican el esófago con la vía aérea y causan episodios de intensa disnea o neumonías aspirativas de repetición.

-----O-----

Además de las posibles complicaciones generales asociadas a cualquier procedimiento quirúrgico , la cirugía laparoscópica asocia unas complicaciones específicas que aunque infrecuentes debemos reconocer ¿Cuál de las siguientes no es una de ellas?

1. Alcalosis respiratoria (Por absorción de CO₂)
2. Enfisema subcutáneo
3. Embolia gaseosa
4. Dolor de hombro referido (por irritación diafragmática)

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Todas las siguientes son complicaciones específicas de la cirugía laparoscópica menos la respuesta número 1 , en la cirugía laparoscópica se puede producir una ACIDOSIS respiratoria por absorción de CO₂

-----O-----

Según el TNM de cáncer colorrectal es falso que :

1. Los pacientes con tumores T1 tienen afectación sólo hasta la submucosa.
2. Los tumores T2 afectan a la grasa del mesorrecto.
3. Los tumores clasificados como Tis no atraviesan la membrana basal.
4. Los tumores T4 son aquellos que afectan a los órganos adyacentes

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Es importante que estudies la clasificación TNM del cáncer colorrectal.

En el cáncer de recto extraperitoneal, que no tiene serosa, la presencia de un tumor T3 quiere decir que invade la grasa del mesorrecto.

T2, tanto en colon como en recto significa afectación de la capa muscular.

El tratamiento de elección en pacientes con hemorroides externa trombosada y dolorosa consiste en:

1. Hemorroidectomía.
2. Incisión de las hemorroides y evacuación de coágulos sanguíneos (trombectomía).
3. Ligadura de las hemorroides con bandas de caucho.
4. Inyección de una solución esclerosante.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Las hemorroides externas no suelen provocar síntomas salvo que estén complicadas, por lo que generalmente no requieren tratamiento. La complicación que sí requiere tratamiento es la trombosis de hemorroides externa. En ese caso se puede optar por realizar una trombectomía o una hemorroidectomía. Se prefiere esta última porque resuelve la complicación y el dolor, además de evitar recidivas de este cuadro.

En un individuo de edad avanzada que acude a Urgencias con dolor abdominal agudo, de localización epigástrica que irradia a hipocondrio izquierdo y espalda, vómitos e intolerancia al alimento, con una analítica en la que destaca un aumento de la amilasa y lipasas séricas, ¿cuál sería la actitud ACONSEJABLE?

1. Administrar antibióticos y esperar evolución.
2. Esfinterotomía endoscópica urgente.
3. Dieta absoluta, sueroterapia, analgesia endovenosa y esperar evolución.
4. Dieta absoluta, sueroterapia y laparotomía exploratoria.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El caso que nos plantean corresponde a una pancreatitis aguda. Repasemos las distintas opciones de respuesta:

- 1.- La administración profiláctica de antibióticos no está indicada.
- 2.- La esfinterotomía endoscópica urgente (< 72 horas) para extracción de coledocolitiasis se indica en caso de colangitis asociada.
- 3.- La opción de respuesta correcta (manejo inicial de toda pancreatitis aguda) es la 3.
- 4.- La intervención quirúrgica urgente no está indicada en estos momentos (no existen datos de necrosis pancreática infectada ni complicación abdominal susceptible de resolución quirúrgica).

La colecistectomía laparoscópica tiene como ventaja sobre la colecistectomía por laparotomía:

1. La reducción de la estancia hospitalaria.
2. Permite conservar la vesícula.
3. No se asocia a lesiones de la vía biliar.
4. Es una técnica exenta de mortalidad.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Las principales ventajas de la laparoscopia, en relación con la cirugía convencional, son una menor agresividad para el paciente, una recuperación más rápida y una menor tasa de complicaciones (respuesta 1 correcta). Por ello, se ha convertido en la técnica de elección para determinadas intervenciones: colecistectomías, funduplicaturas, salpingoclastis, tratamiento quirúrgico de la acalasia y cuando no existe un diagnóstico claro.

El resto de las opciones, si las analizas con detalle, no es que sean falsas, sino que son ridículas:

- R2: ¿Cómo vas a conservar la vesícula en una colecistectomía?

- R3: Cualquier intervención sobre la vía biliar puede lesionarla.

- R4: “Exenta”, “nunca”, “en ningún caso”, “es imposible”. Ante la duda, no debes confiar en una respuesta así.

-----O-----

¿Qué debemos sospechar ante un paciente que inicia de forma súbita un cuadro de dolor abdominal en epigastrio compatible a la exploración con “abdomen en tabla”?

1. Obstrucción intestinal
2. Apendicitis aguda
3. Diverticulitis aguda
4. Ulcus perforado

Resp. Correcta: 4

Comentario: Pregunta sobre orientación del diagnóstico según la localización del dolor, en el cual debemos saber que un dolor súbito epigástrico asociado a abdomen en tabla es muy característico de un ulcus perforado. El resto de respuestas generan dolor en otros cuadrantes del abdomen

-----O-----

Con respecto al divertículo de Zenker, señale la afirmación FALSA:

1. Se localiza en la parte posterior de la hipofaringe, por encima del músculo cricofaríngeo.
2. Se origina por tracción, debido a una incoordinación de la musculatura faríngea, que favorece la herniación de la mucosa a través del triángulo de Killian).
3. Puede causar halitosis y regurgitación.
4. El tratamiento consiste en la miotomía cricofaríngea endoscópica o quirúrgica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El divertículo de Zenker se origina por pulsión (opción 2 falsa, por lo que la marcamos), debido a una incoordinación de la musculatura faríngea (que favorece la herniación de la mucosa a través del triángulo de Killian). Puede causar halitosis, regurgitación, disfagia orofaríngea, tos, neumonía por aspiración e incluso una obstrucción completa por compresión. Como complicaciones, puede ocasionar episodios de broncoaspiración, formación de fistulas entre el divertículo y la tráquea, hemorragia intradiverticular (sobre todo, con el ácido acetilsalicílico [AAS]) y, más raramente, la aparición de un carcinoma epidermoide dentro del divertículo (0,4%). El tratamiento se indica en los pacientes sintomáticos o con divertículos grandes y consiste en miotomía cricofaríngea, bien por vía endoscópica o quirúrgica, añadiendo la

extirpación del divertículo si es de gran tamaño (excepcionalmente puede degenerar). Si es pequeño, la miotomía es suficiente.

¿Cuál de estos enfermos es candidato inequívoco para realizar una cirugía de la úlcera con vagotomía asociada?

1. Paciente de 45 años, que debuta con dolor epigástrico súbito hace 2 horas, y es diagnosticado de perforación ulcerosa en primera porción duodenal.
2. Paciente de 47 años, que debuta con cuadro de melenas y es diagnosticado por endoscopia de úlcera sangrante en primera porción duodenal, que no deja de sangrar, tras coagulación e inyección de adrenalina.
3. Paciente de 64 años, con brotes ulcerosos repetidos desde hace 6 años, con erradicación de *H. pylori* hace dos años, que se tratan de forma sintomática con ranitidina, y que presenta ahora una perforación pilórica ulcerosa, de 7 horas de evolución.
4. Paciente de 49 años, que sigue tratamiento habitual con indometacina por artritis reumatoide y presenta una gastritis erosiva antral.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Aunque los pacientes con úlcera perforada se van a tratar mayoritariamente mediante cierre simple de la perforación y tratamiento médico posterior, a los pacientes con factores de riesgo de recidiva por cronicidad o por encontrarse previamente en tratamiento antisecreto, se les debe realizar una vagotomía troncular para eliminar el ácido de forma definitiva.

No es indicación de colecistectomía laparoscópica:

1. Cálculos mayores de 2,5 cm
2. Mieloma múltiple
3. Pancreatitis aguda litiásica
4. Colelitiasis en pacientes jóvenes

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Hay indicación de colecistectomía laparoscópica cuando la litiasis es sintomática en forma de cólicos de repetición o infecciones como la pancreatitis, colangitis o colecistitis. Es recomendable la cirugía en casos de litiasis asintomáticas que puedan causar problemas a largo plazo como son la colelitiasis en gente joven o los cálculos grandes que pueden erosionar la pared de la vesícula y dar lugar a fistulas con el tracto digestivo o la vía biliar.

Respecto a la laparoscopia una de las siguientes afirmaciones no la define:

1. Es preciso crear una campana de trabajo intraabdominal mediante la insuflación. de dióxido de carbono manteniendo un neumoperitoneo con una presión controlada en torno a 12 mmHg.
2. Las cirugías abdominales previas y la obstrucción intestinal han sido consideradas tradicionalmente una contraindicación relativa.
3. La mejor indicación para la cirugía laparoscópica son las situaciones de riesgo vital , con paciente en

shock como la cirugía de extrema urgencia por politraumatismo.

4. Ofrece ventajas frente a la cirugía convencional en cuanto a menor dolor, infección y eventración de heridas siendo la recuperación funcional más rápida, pero la laparoscopia es un abordaje abdominal más protrombótico que la laparotomía.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La laparoscopia consiste técnicamente en lo que dice la respuesta 1 y tiene las ventajas fundamentales que reseña la respuesta 4.

Aunque la cirugía previa y los cuadros obstructivos son una contraindicación relativa, también lo es la inestabilidad hemodinámica y el shock.

-----O-----

Un paciente que, tras una sobrecarga alcohólica, presenta vómitos copiosos y, varias horas después, intenso dolor precordial, enfisema subcutáneo y en Rx tórax derrame pleural izquierdo. ¿Qué proceso le sugiere?

1. Pericarditis aguda.
2. Neumonía aspirativa.
3. Neumotórax espontáneo.
4. Rotura espontánea de esófago.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Se trata de un síndrome de Boerhaave, que no es otra cosa que una perforación esofágica relacionada con vómitos, normalmente en el contexto de un paciente bebedor. La presencia de enfisema subcutáneo es muy indicativa de que puede haberse producido esta complicación.

-----O-----

Los siguientes tratamientos serían apropiados en un paciente con pseudoquistes en la cabeza del páncreas, EXCEPTO:

1. Cistoduodenostomía.
2. Cistoyeyunostomía.
3. Escisión del segmento pancreático afectado.
4. Drenaje externo si existe sobreinfección

Resp. Correcta: 3

Comentario: La cirugía de los pseudoquistes pancreáticos, cuando está indicada, depende inicialmente de la localización del pseudoquiste. Así en aquellos casos en los que el pseudoquiste asienta en la cola pancreática (los menos frecuentes) una opción de tratamiento adecuada pasa por escisión de la cola pancreática con el pseudoquiste que incluye (pancreatectomía distal) siendo esta la opción quirúrgica con menor tasa de recurrencia (alrededor del 3 %). En los casos en los que el pseudoquiste asienta en la cabeza o en el cuerpo pancreático se prefiere la utilización de técnicas de derivación interna (cistoyeyunostomía, cistogastrostomía o cistoduodenostomía) reservando las derivaciones externas para las complicaciones infecciosas del mismo o en los casos de "cápsula" inmadura.

Paciente mujer de 66 años que desde hace aproximadamente 6 meses presenta dolor mesogástrico intenso, posprandial, irradiado al flanco derecho. Además comenta distensión abdominal, náuseas, vómitos y pérdida de peso (6 kilos) acompañada de anorexia, astenia y cambios en el hábito intestinal. Aporta una analítica en la que destaca una anemia microcítica. Ante estos hechos, usted ordenaría:

1. Iniciar tratamiento con hierro y repetir analítica.
2. Pedir una TAC abdominal.
3. Pedir sangre oculta en heces.
4. Una colonoscopia.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Ante un paciente mayor de 50 años con clínica sugerente de neoplasia, debe iniciarse el estudio sin demora. El diagnóstico electivo de cáncer de colon se establece por colonoscopia y biopsia (respuesta 4 correcta). La sangre oculta en heces forma parte del cribado poblacional por lo que no se usa en pacientes sintomáticos, mientras que la TAC se hace tras la confirmación diagnóstica para el estudio de extensión, salvo que se sospechen complicaciones tumorales.

Ante un paciente diagnosticado de acalasia, señale la afirmación FALSA:

1. Se caracteriza por aperistalsis esofágica y relajación incompleta del esfínter esofágico inferior tras la deglución.
2. Puede degenerar a cáncer esofágico, por lo que precisa endoscopias de control periódicas.
3. Una vez identificada su causa, el tratamiento resulta curativo.
4. La dilatación endoscópica esofágica y la miotomía modificada de Heller constituyen los dos tratamientos más eficaces.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La acalasia es una disfagia esofágica muscular continua de etiología desconocida, no susceptible de ningún tratamiento curativo, sino de un tratamiento SINTOMÁTICO (opción 3 falsa, por lo que la marcamos). Las demás opciones de respuesta son totalmente correctas. El patrón manométrico típico es:

- En el EEI, Presión basal N/ + relajación incompleta/ausente tras deglución.
- En el esófago: Aperistalsis esofágica.

La clínica típica consiste en: disfagia progresiva constante (sólidos + líquidos), regurgitación no ácida nocturna, pirosis, halitosis, dolor tórax postingesta y peso progresiva.

Globalmente, disponemos de cuatro opciones terapéuticas:

- 1) Dilatación endoscópica esofágica con balón.
- 2) Miotomía modificada de Heller+ técnica antirreflujo (funduplicatura).
- 3) Relajantes musculares orales.
- 4) Inyección endoscópica intramuscular de toxina botulínica.

Ante un paciente con disfagia secundaria a adenocarcinoma estenosante de la unión gastroesofágica(T3N1M0) que va a requerir nutrición prolongada durante el

tratamiento neoadyuvante, se indica realizar:

1. Gastrostomía de alimentación.
2. Ileostomía de protección
3. Yeyunostomía de alimentación.
4. Colostomía descompresiva.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La yeyunostomía de alimentación es una técnica empleada en pacientes oncológicos de tracto intestinal superior e intolerancia oral para poder ser nutridos. Se prefiere respetar el estómago (gastrostomía de alimentación) ya que en muchos casos, en la reconstrucción tras una esofagectomía, es utilizado para realizar una plastia y anastomosis.

-----o-----
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las perforaciones esofágicas NO es correcta?

1. La causa mas frecuente son los cuerpos extraños
2. El dolor es el síntoma mas frecuente, suele ser intenso y de localización cervical o retroesternal en función de la localización de la perforación.
3. Los contrastes hidrosolubles son de elección para el diagnóstico de rotura esofágica.
4. Los pacientes estables, sin signos de sepsis y con perforaciones pequeñas son candidatos a tratamiento conservador.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La causa más frecuente de perforación esofágica es la iatrogénica: por endoscopia terapéutica o por miotomía de Heller; otras causas serían: síndrome de Boerhaave (perforación post-emética), cuerpos extraños, traumatismos e ingesta de cáusticos. La respuesta FALSA es la nº1.

Los síntomas más frecuentes de perforación esofágica son: dolor retrosternal intenso, crepitación o enfisema, fiebre, disfagia, insuficiencia cardio-respiratoria.

La técnica diagnóstica de elección son los estudios con contraste oral hidrosoluble (esofagograma o TC con contraste). La radiografía simple cervical y torácica pueden evidenciar: derrame pleural, neumomediastino, enfisema subcutáneo, ensanchamiento mediastínico, desviación traqueal anterior.

Las opciones terapéuticas son el tratamiento no operatorio (casos seleccionados) o una intervención quirúrgica (reparación, drenajes, etc).

Las condiciones para optar por un tratamiento no operatorio son: perforación esofágica precoz y contenida de pequeño tamaño, ausencia de sepsis, y localización alta de la perforación (especialmente en esófago cervical).

-----o-----
Paciente diagnosticado de pancreatitis crónica y pseudoquistes que acude por dolor abdominal epigástrico, vómitos alimenticios y pérdida de peso. La complicación que PROBABLEMENTE presenta dicho paciente es:

1. Obstrucción duodenal.

2. Obstrucción del colédoco.
3. Rotura del pseudoquiste a peritoneo.
4. Fístula pancreática a colon transverso.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El pseudoquiste pancreático se define como una “colección líquida encapsulada sin necrosis, rica en amilasa, secundaria a una disrupción del conducto Wirsung o sus ramas”. Es la complicación más frecuente de la pancreatitis aguda edematosa, aunque es su etiología más prevalente es la Pancreatitis Crónica”. La clínica consiste en: asintomático, hiperamilasemia mantenida, dolor epigástrico o datos de “pseudoquiste complicado”: infección/sepsis, hemorragia, ascitis pancreática, obstrucción duodenal o biliar. La evolución habitual del pseudoquiste es su resolución espontánea, por lo que suele bastar con un seguimiento ecográfico periódico. Estaría indicado su drenaje percutáneo en caso de pseudoquiste muy sintomático, fiebre, crecimiento rápido o “pseudoquiste complicado”. El paciente de la pregunta presenta un cuadro obstructivo (vómitos alimentarios y dolor epigástrico), por lo que nos enfrentamos, probablemente, a una obstrucción duodenal secundaria a un pseudoquiste de gran volumen (respuesta 1 correcta). La ausencia de ictericia, peritonitis o sangrado/diarrea descartan las demás complicaciones contenidas en las opciones de respuesta.

Respecto a la cirugía bariátrica es falso que:

1. La indicación para cirugía bariátrica viene dada por un IMC > 30 kg/m² con comorbilidades o un IMC > 40 kg/m².
2. La hernia interna de Petersen es una complicación tardía del bypass que se produce al perder peso, especialmente con la pérdida máxima de peso, que acontece alrededor del primer año, dejando un espacio entre el meso del asa alimentaria y el mesocolon transverso que puede causar una obstrucción intestinal.
3. La principal causa de reintervención en un paciente operado previamente de obesidad mórbida es la ausencia de pérdida de peso adecuada y mantenida o la falta de mejora en sus comorbilidades.
4. El montaje quirúrgico del bypass se caracteriza por un asa alimentaria que mide más de un metro y un reservorio gástrico en torno a 15-30 cc.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La indicación de cirugía bariátrica es el IMC mayor de 40 o mayor de 35 con comorbilidades.

Repasa los conceptos de las otras 3 respuestas, importantes para repasar los conceptos importantes sobre la hernia de Petersen, las complicaciones de la cirugía y los aspectos técnicos del bypass.

¿Cuál de las siguientes complicaciones es más típica de la enfermedad de Crohn que de la colitis ulcerosa?

1. Megacolon tóxico.
2. Colangiocarcinoma.
3. Degeneración maligna.

4. Fístulas internas.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El megacolon tóxico es una complicación típica de la colitis ulcerosa. Del mismo modo la aparición de displasia o cáncer así, colangiocarcinoma son más característicos de la colitis ulcerosa. Sin embargo la enfermedad de Crohn tiene un patrón fistulizante típico, produciendo fístulas Internas, esto ocurre porque produce una afectación inflamatoria transmural de toda la pared intestinal.

-----O-----

En un paciente que ha sufrido una pancreatitis aguda días antes, el dolor no disminuye y la fiebre no baja. Las cifras de amilasa siguen elevadas y se palpa una masa en epigastrio dolorosa a la palpación. La ecografía confirma el diagnóstico de pseudoquiste en la cabeza del páncreas. Se decide esperar, pero a las seis semanas no se ha resuelto sino que ha aumentado de tamaño. Se decide intervenir. Todas las siguientes técnicas son útiles, EXCEPTO:

1. Cistogastrostomía.
2. Cistoyeyunostomía en Y de Roux.
3. Duodenopancreatectomía cefálica o técnica del Whipple.
4. Drenaje externo si el paciente empeora.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La duodenopancreatectomía cefálica o intervención de Whipple es una operación agresiva, con un elevado índice de complicaciones potencialmente graves, que está indicada como tratamiento potencialmente curativo de los cánceres de cabeza de páncreas (respuesta 3).

El tratamiento quirúrgico de los pseudoquistes de páncreas, cuando está indicado, consiste en una derivación interna, es decir drenar el contenido del pseudoquiste (secreciones pancreáticas) al tubo digestivo (que es donde vierte de forma fisiológica el páncreas su secreción) y esto se hace con diferentes técnicas como la cistoyeyunostomía en Y de Roux, la cistogastrostomía y la cistoduodenostomía. En aquellos casos en los que el pseudoquiste se localice en la cola pancreática una opción adecuada es la pancreatectomía distal que incluye el pseudoquiste. Sólo en los casos en los que se produce la infección del pseudoquiste con importante repercusión clínica estará indicado realizar un drenaje externo.

-----O-----

Paciente con antrectomía + Billroth II presenta dolor epigástrico continuo, vómitos biliares y alimenticios que no alivian el dolor. ¿Cuál sería su actitud terapéutica?

1. Transformar el Billroth II en Billroth I.
2. Gastroyeyunostomía en Y de Roux + vagotomía troncular.
3. Interposición de un asa yeyunal antiperistáltica.
4. Técnica antirreflujo.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Se trata de una clínica característica de gastritis por reflujo alcalino. Se realiza vagotomía para eliminar la secreción ácida completamente y reconstrucción en Y Roux para eliminar el reflujo alcalino,

En relación con la patología hemorroidal, señale la respuesta correcta:

1. En el caso de la trombosis hemorroidal externa, no está indicado el tratamiento en la fase aguda
2. Las hemorroides grado III responden a técnicas no quirúrgicas como son la esclerosis, las ligaduras con bandas y la fotocoagulación
3. Las hemorroides grado III se caracterizan por prurito y sangrado, siendo las crisis hemorroidales poco frecuentes
4. El prolapso hemorroidal agudo trombosado se produce por dificultad en el retorno venoso y da lugar a una trombosis.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La trombosis hemorroidal aguda constituye una complicación de las hemorroides externas, caracterizada por nódulo violáceo de aparición brusca y dolor intenso. En pacientes con menos de 72 horas de evolución se recomienda una trombectomía o hemorroidectomía urgente. En pacientes con más de 72 horas de evolución, se recomienda la administración de AINES, laxantes, venotónicos..

El prolapso hemorroidal, complicación de las hemorroides internas, se gradúa de I-IV. El tratamiento electivo en las formas crónicas depende del grado de prolapso:

-grado I: tto.conservador o esclerosis

-grado II: esclerosis o ligadura con banda elástica

-grado III (propaso defecatorio y espontáneo, con reducción manual): ligadura con banda elástica o cirugía

-grado IV: cirugía (hemorroidectomía)

Entre las complicaciones agudas del propaso hemorroidal destacamos la crisis hemorroidal aguda (dolor) y el prolapso hemorroidal agudo trombosado (trombosis por dificultad del retorno venoso) (respuesta correcta nº4). El tratamiento del prolapso agudo trombosado consiste en: reducir el prolapso, AINES, laxantes, venotónicos y baños de asiento.

Hombre de 56 años, fumador y bebedor, que presenta disfagia principalmente a sólidos, regurgitaciones y dolor retroesternal. Se le realiza endoscopia, encontrando tumoración de 3 cm estenosante en esófago distal. La biopsia es informada como adenocarcinoma. En la TC torácica se observa engrosamiento de 2 cm en esófago torácico sin metástasis a distancia. En la ecografía transesofágica se observa tumoración que invade la muscular, sin observar adenopatías mediastínicas. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

1. Quimioradioterapia neoadyuvante y posteriormente esofagectomía.
2. Radioterapia como tratamiento definitivo.
3. Colocación de prótesis de tipo stent.

4. Esofagectomía y plastia gástrica con anastomosis cervical.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Se trata de un paciente joven sin comorbilidad importante con un adenocarcinoma de esófago torácico de 2 cm de diámetro con estadiaje T2 N0 M0. En este caso nos podemos plantear un tratamiento con intención curativa por lo que descartaríamos las respuestas 2 y 3. Una vez hemos optado por el tratamiento quirúrgico, aunque es cierto que la tendencia actual es a tratar con neoadyuvancia a la mayoría de los pacientes, en este caso nos plantean un tumor de tan sólo 2 cm y que invade sólo la capa muscular sin adenopatías. Por eso, la neoadyuvancia en este paciente no va a aportar ventajas sobre una cirugía oncológica radical adecuada.(Manual CTO10ª ed. CG. 1.3. Fig 15)

-----o-----

Una mujer de 30 años con antecedentes de alergia a penicilinas, asma intrínseco, EPI hace 3 años, acude al servicio de urgencias por presentar cuadro de 24 horas de evolución de dolor en fosa ilíaca derecha asociado a vómitos. En la exploración física presenta dolor selectivo en fosa ilíaca derecha con marcada defensa, con signo de rebote local. En la analítica destaca leucocitosis de 11.500 y una PCR de 25. No refiere clínica digestiva ni ginecológica sobreañadida. Test de embarazo negativo. Respecto al cuadro sospechado, señale la falsa:

1. Ante cualquier cuadro de abdomen agudo la indicación temprana de cirugía urgente, evita una morbilidad mayor.
2. La valoración por ginecología puede ayudar al diagnóstico. Si éste no es claro, puede mantenerse en observación para nueva reevaluación clínica.
3. La ecografía abdominal puede ser de utilidad para el diagnóstico diferencial del dolor en fosa ilíaca derecha.
4. La laparoscopia diagnóstica es una opción a tener en cuenta ante cuadros de dolor abdominal agudo, especialmente si no queda claro el origen con la exploración física y las pruebas de imagen .

Resp. Correcta: 1

Comentario: Ante un abdomen agudo, si hay estabilidad y no hay signos de gravedad clínica se debe hacer diagnóstico diferencial con cualquiera de las estrategias de las respuestas 2-3-4.

-----o-----

Un paciente intervenido hace unos años por una úlcera duodenal acude a consulta por la aparición de dolor abdominal. Ante la sospecha de una nueva úlcera se le practica una endoscopia que muestra úlceras en bulbo duodenal y antro pilórico. La gastrina sérica del paciente está elevada, y se eleva tras la administración de secretina. ¿Cuál sería el tratamiento ÓPTIMO de este paciente teniendo en cuenta su sospecha diagnóstica?

1. Antagonistas H2 en dosis altas.
2. Omeprazol.
3. Resección completa del tumor.
4. Gastrectomía total.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La primera sospecha diagnóstica ante un cuadro clínico con úlceras múltiples e hipergastrinemia debe ser el síndrome de Zollinger-Ellison (gastrinoma), que además se confirma con la elevación de la gastrina tras la estimulación con secretina. En relación al tratamiento de elección es siempre quirúrgico, con extirpación del tumor, si se puede (ya que tiene una gran tendencia a la diseminación y a veces no es sencilla su localización).

-----o-----

Respecto al reflujo gastroesofágico y la cirugía antirreflujo, la siguiente afirmación es falsa:

1. La enfermedad de Barrett sin displasia no tiene indicación absoluta de funduplicatura, mientras que la enfermedad de Barrett con displasia de alto grado es indicación de esofagectomía.
2. Las funduplicaturas tienden a hacerse calibradas para evitar la estenosis o dejarlas excesivamente laxa.
3. Las complicaciones por la ERGE y el reflujo con clínica persistente pese a tratamiento médico son indicaciones de cirugía.
4. La acalasia y la hernia hiatal paraesofágica tipo II no suele asociar una cirugía antirreflujo.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La acalasia y la hernia hiatal paraesofágica tipo II, requieren tratamiento quirúrgico que debe asociar alguna técnica antirreflujo ya que estas entidades o las técnicas que utilizan para su reparación dejan al paciente en situación refluxógena.

-----o-----

Respecto a la colecistitis aguda, señale el enunciado falso:

1. El diagnóstico de elección es La ECO abdominal que identifica aumento de grosor de la pared, distensión de la vesícula o líquido libre.
2. Las colecistitis enfisematosas y las colecistitis alitiásicas rara vez evolucionan a sepsis pudiéndose manejar de forma conservadora.
3. Suele indicarse colecistectomía urgente si han pasado menos de 72 horas desde que se inició el cuadro clínico, y tratamiento antibiótico si se trata de un cuadro muy evolucionado o el paciente presenta alta comorbilidad.
4. La colecistostomía percutánea es una alternativa a la cirugía, ante fracaso del antibiótico especialmente en pacientes ancianos.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Las colecistitis enfisematosas y alitiásicas tienen más fracaso terapéutico con el manejo conservador.

-----o-----

Respecto al tratamiento quirúrgico del pseudoquiste, señale la respuesta NO correcta:

1. El pseudoquiste es la complicación más frecuente de la pancreatitis aguda.
2. La mayoría se producen por una disrupción del conducto pancreático.
3. El 85% se localizan en el cuerpo y cola del páncreas.
4. Presentan concentraciones bajas de amilasa, mucina y CEA.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Aunque es la complicación más frecuente de la pancreatitis aguda, es mucho más frecuente encontrarlo en el contexto de un pancreatitis crónica. A diferencia de las colecciones pancreáticas, suelen presentar comunicación con el ducto pancreático, y se localizan muy raramente en la cabeza.

Lo más importante de esta pregunta es conocer que cursan con elevación de amilasa y concentraciones bajas de mucina y CEA, lo que permite diferenciarlos de otras lesiones quísticas pancreáticas.

-----O-----

Varón de 60 años de edad acude a consulta con cuadro de halitosis y regurgitación de saliva y partículas de alimento consumidos varios días antes. Tiene antecedentes de procesos bronconeumónicos de repetición y crisis de tos con la deglución. ¿Ante qué proceso patológico nos encontramos con mayor probabilidad?

1. Divertículo de Zenker.
2. Anillo de Schatzki.
3. Adenocarcinoma de esófago.
4. Síndrome de Mallory-Weiss.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El divertículo de Zenker se localiza en la parte posterior de la hipofaringe, por encima del músculo cricofaríngeo y debajo del músculo constrictor inferior de la faringe. Se originan por pulsión, debido a una mala coordinación de la musculatura faríngea. Puede causar halitosis, regurgitación, disfagia orofaríngea e incluso una obstrucción completa por compresión.

Como *complicaciones*, puede producir episodios de broncoaspiración, formación de fistulas entre el divertículo y la tráquea, hemorragia intradiverticular (sobre todo con la aspirina) y, más raramente, la aparición de un carcinoma epidermoide dentro del divertículo. La colocación de una sonda nasogástrica o la realización de una endoscopia en estos pacientes tiene riesgo de perforación del divertículo, por lo que deben evitarse. El *tratamiento* es quirúrgico, realizando una **miotomía cricofaríngea** y extirpando el divertículo. Si es pequeño, la miotomía aislada puede ser suficiente.

-----O-----

El procedimiento consistente en colocar un tubo en el estómago que salga a la piel con la intención de utilizarlo para alimentar a un paciente se llama:

1. Gastrectomía.
2. Gastrostomía.
3. Gastrotomía.
4. Gastroplastia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Es conveniente recordar que:

- O stomía significa comunicar un órgano o cavidad con el exterior.
- Tomía: incisión
- Ectomía extirpación
- plastia: cambiar la forma de un órgano, remodelar, reparar.

-----o-----

Señale la INCORRECTA en relación al síndrome de Plummer-Vinson:

1. Tienen un aumento de riesgo de cáncer de esófago.
2. El tratamiento con hierro revierte la disfagia.
3. Aparecen membranas en la parte anterior del esófago distal.
4. Puede aparecer glositis.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El síndrome de Plummer- Vinson se asocia a la aparición de membranas en la hipofaringe o esófago superior, provocando disfagia orofaríngea. Se asocia, a su vez, a un estado carencial de hierro y, por tanto, aparece glositis. Esta situación se asocia también a un mayor riesgo de cáncer faríngeo y esofágico.

-----o-----

La emergencia quirúrgica extrauterina más frecuente en la mujer embarazada es:

1. Apendicitis aguda.
2. Diverticulitis aguda.
3. Quiste ovárico roto.
4. Compresión aguda de cava por útero grávido.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La apendicitis aguda es el abdomen agudo quirúrgico más frecuente de forma general y también en las mujeres embarazadas. Aunque en este grupo concreto debemos tener también en cuenta la posibilidad de que se presenten complicaciones propias del embarazo, éstas son menos frecuentes que la apendicitis.

-----o-----

Entre las causas de carcinoma epidermoide de esófago, se consideran todas las siguientes, EXCEPTO:

1. Tabaco.
2. Acalasia.
3. Síndrome de Plummer-Vinson.
4. Reflujo gastroesofágico.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Entre los diferentes tipos de cáncer de esófago, debemos distinguir dos variedades principales: el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma esofágico. En realidad, lo que están haciendo en esta pregunta es tratar

que los confundamos entre sí. El carcinoma epidermoide esofágico se ha relacionado con hábitos como el tabaco y el alcohol, siendo además una asociación fuerte. La acalasia también está vinculada a este tipo de cáncer, aunque no justifica un número de casos tan elevado como el tabaquismo. Por último, el síndrome de Plummer-Vinson, que se asocia a la anemia ferropénica, también se considera factor de riesgo. La opción de respuesta correcta es la 4. El reflujo gastroesofágico produce una metaplasia columnar en la región inferior del esófago, conocida como esófago de Barrett. En ocasiones, esta metaplasia se complica con displasia de diferentes grados, lo que finalmente deriva en un adenocarcinoma esofágico. Recuerda que, topográficamente, el esófago de Barrett aparece en el tercio inferior, mientras que el carcinoma epidermoide es más propio del tercio medio.

¿Cuál de las siguientes medidas empleadas en el tratamiento conservador de la patología hemorroidal es incorrecta?

1. Dieta rica en fibra y abundante agua
2. Evitar el sedentarismo
3. Tratamiento tópico con corticoides durante 2 semanas
4. Baños de asiento con agua templada

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre el manejo conservador de la patología hemorroidal, en este caso tenemos que señalar la medida incorrecta, la respuesta correcta sería la número 3 puesto que el tratamiento tópico con pomadas que llevan corticoides se realizan únicamente en fase aguda y durante no más de 5-7 días

Se evalúa a un varón de 65 años para la resección de un cáncer de colon derecho. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al abordaje quirúrgico es verdadera?

1. La laparoscopia se asocia a una tasa más alta de recidiva locorregional
2. La cirugía laparoscópica puede ser un abordaje para cáncer de colon incluso en casos de urgencia
3. La laparoscopia está contraindicada en tumores T4
4. La colectomía laparoscópica no ha demostrado ser equivalente a la colectomía abierta con respecto a la supervivencia a largo plazo.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los estudios realizados hasta la fecha en cáncer de colon muestran la no inferioridad de la laparoscopia frente a la cirugía convencional en términos de supervivencia global y libre de enfermedad. Además la laparoscopia aporta las ventajas del abordaje mínimamente invasivo precisando el paciente menor requerimientos analgésicos, menor íleo paralítico y menor estancia hospitalaria. Los Tumores T4 ni la cirugía urgente es una contraindicación absoluta para el abordaje laparoscópico

Las hemorroides se consideran de tercer grado cuando:

1. Se prolapsan temporalmente en el momento de la defecación.

2. Se prolapsan indefinidamente y han de reducirse manualmente.
3. Se trombosan.
4. Se necrosan y se ulceran.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Las hemorroides internas se producen por dilatación del plexo venoso hemorroidal interno formado por venas rectales superior y media. Se clasifican en IV grados según la intensidad del prolapso. El grado I permanece en recto y su tratamiento es conservador. El grado II prolapsa a través del ano cuando el paciente puja, reduciéndose espontáneamente y se trata con ligadura de vaina de caucho o bien esclerosis. El grado III prolapsa cuando el paciente puja pero es necesaria la restitución manual y el tratamiento es con ligadura de vaina de caucho o en ocasiones hemorroidectomía. El grado IV es el prolapso persistente no reductible cuyo único tratamiento posible es la hemorroidectomía.

-----o-----

Un paciente presenta un tumor de sigma perforado. En el estudio anatomopatológico se aprecian dos adenopatías metastásicas. El estadiaje será:

1. Tx N2
2. T3 N1
3. T4 N1
4. T3 N2

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Es importante que recuerdes el TNM del cáncer colorrectal:

Tis: sólo mucosa

T1 afectación submucosa

T2 llega a la muscular

T3 afecta a la subserosa en el colon y a la grasa de mesorrecto en el recto.

T4 afecta a órganos vecinos. Los tumores perforados se consideran T4

-----o-----

Un paciente con un pseudoquiste pancreático de 3 cm. como consecuencia de una pancreatitis aguda sufre un descenso del hematocrito y en la exploración llama la atención aumento de tamaño del quiste y un soplo en el área esplénica. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?:

1. Disección del quiste hacia el bazo y rotura del mismo.
2. Rotura en cavidad peritoneal.
3. Formación de un pseudoaneurisma por erosión de la arteria esplénica.
4. Rotura del quiste en víscera hueca.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Nos encontramos ante un paciente con diagnóstico previo de un pseudoquiste pancreático de tamaño conocido en el que se produce caída brusca del hematocrito coincidente con el aumento del tamaño del pseudoquiste y soplo en el área esplénica, lo que nos debe hacer pensar en una complicación del mismo de tipo hemorrágico. Así pues por los datos que nos aportan el cuadro clínico es compatible con la rotura de la arteria esplénica que provoca sangrado dentro del pseudoquiste en lo que se denomina un pseudoaneurisma. Este cuadro clínico puede acompañarse a veces de hemorragia digestiva cuando el pseudoquiste tiene comunicación con el conducto pancreático produciéndose salida de la sangre al tubo digestivo a través de la papila. Se trata de una urgencia cuyo diagnóstico y tratamiento se realizan mediante una arteriografía esplénica con embolización de la arteria esplénica responsable del sangrado.

-----O-----

Mujer de 58 años con antecedente de pirosis de larga evolución para la que se automedica con antiácidos y con Ranitidina. Consulta porque desde hace tres meses nota con la ingesta de alimentos dolor en area retroesternal inferior. En una endoscopia se observa en esófago distal, zonas con mamelones y mucosa con múltiples ulceraciones. El estudio histológico muestra datos de esofagitis con metaplasia intestinal y zonas con abundantes células de aspecto displásico, algunas incluso atravesando la membrana basal epitelial. Entre las siguientes ¿qué medida terapéutica sería de elección?

1. Omeprazol y revisión endoscópica al año.
2. Omeprazol y revisión endoscópica a los seis meses.
3. Esofagectomía del área afecta.
4. Omeprazol y revisión a los dos meses.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El esófago de Barrett consiste en la presencia de un **epitelio columnar de tipo intestinal**, que aparece en algunos pacientes con esofagitis por reflujo gastroesofágico. Este cambio del tipo de epitelio obedece a fenómenos de **metaplasia**, e implica un riesgo de malignización. En el caso que nos describen, nos hablan de un esófago de Barrett con displasia severa, lo que implica un altísimo riesgo de desarrollar un adenocarcinoma de esófago. De hecho, en este caso ya lo está desarrollando, puesto que nos mencionan que existen algunas zonas donde las células están rompiendo la membrana basal. Por ello, no podemos conformarnos con un tratamiento médico, siendo obligada la resección quirúrgica (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Varón de 55 años, fumador y bebedor importante, sin otros antecedentes, que acude a consulta por disfagia para sólidos progresiva de pocos meses de evolución, junto con pérdida de 10 kg de peso y astenia. Su sospecha diagnóstica es:

1. Acalasia.
2. Esclerodermia.
3. Carcinoma esofágico.
4. Estenosis péptica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso importante sobre el carcinoma de esófago. Sospecha siempre cáncer de esófago en varones, con antecedentes personales de alcoholismo y tabaquismo, con disfagia para sólidos de reciente instauración y pérdida de peso.

-----O-----

Paciente varón de 30 años sin antecedentes de interés que tras un fin de semana de excesos gastronómicos acude a tu consulta refiriendo sensación de bulto a través del ano al defecar que se reduce de forma espontánea, rectorragias puntuales y malestar moderado en la región anal. Es la primera vez que le ocurre y se encuentra muy nervioso ¿Cuál de las siguientes actuaciones es la mas correcta?

1. Sospecho que puede tener como primera posibilidad un cáncer de recto , solicitaría una colonoscopia de forma urgente
2. Lo mas probable es que se trate de patología hemorroidal interna (grado II), se podría beneficiar de esclerosis o ligadura con bandas
3. Lo mas probable es que se trate de patología hemorroidal interna (grado III), es necesario indicar tratamiento quirúrgico
4. Creo que tiene un absceso perianal, esta indicado cirugía urgente

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre patología hemorroidal, en este caso clínico nos presentan un varón joven que tras excesos y transgresiones dietéticas refiere patología hemorroidal interna, en este caso las hemorroides se reducen de forma espontánea y se corresponde a un grado II que se podría beneficiar de esclerosis o colocación de bandas

-----O-----

En el dolor anal, es incorrecto :

1. La existencia de dolor tras la defecación es indicativo de fisura anal.
2. La fisura anal implica un tratamiento escalonado cuya indicación final es la esfinterotomía lateral interna por hipertonía del esfínter que condiciona una fisura crónica que no cicatriza con el tratamiento médico.
3. La trombosis hemorroidal solo es tratable con cirugía urgente por causar un dolor lacerante incoercible.
4. Los abscesos perianales asocian datos de inflamación perianal como eritema, fluctuación... y pueden acompañarse de fiebre. Habitualmente precisan drenaje quirúrgico.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La trombosis hemorroidal puede tratarse de forma médica o quirúrgica. La trombectomía quirúrgica acorta el tiempo de duración del dolor especialmente si se realiza en las primeras fases

-----O-----

Respecto al abdomen agudo señale la incorrecta:

1. Lo más importante en la valoración del paciente es la historia clínica y la exploración física
2. Las pruebas de laboratorio y de imagen nos ayudan a confirmar o excluir posibles diagnósticos

3. Abdomen agudo es sinónimo de indicación quirúrgica
4. Si el enfermo está grave o inestable es probable que haya que realizar una exploración quirúrgica

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre semiología de abdomen agudo, las respuestas 1, 2 y 4 son correctas, es importante historiar y explorar al paciente ayudándonos de las pruebas diagnósticas y en caso de que el enfermo presente un abdomen agudo y esté grave, seguramente tendremos que operarlo. La respuesta 3 es incorrecta debido a que abdomen agudo no es sinónimo de indicación quirúrgica, habrá muchos abdomenes agudos que no requieran cirugía

-----o-----

A un paciente de 34 años se le indica cirugía de reflujo gastroesofágico por presentar esofagitis grado II. Con respecto a la funduplicatura tipo Nissen que se le va a realizar, una de las siguientes afirmaciones NO es correcta. Señálela:

1. El abordaje de elección es la vía laparoscópica.
2. El fundus gástrico rodea el esófago 180 °.
3. Si queda muy laxa, la sintomatología puede recidivar.
4. Si el paciente presentara un esófago corto, podría asociarse una gastroplastia de Collis.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La funduplicatura de Nissen rodea con el fundus, toda la circunferencia del esófago (360 grados - opción 2 incorrecta, por lo que la marcamos -). Las parciales como el Toupet (180 grados posterior) solo se emplean en la actualidad en la cirugía de la acalasia para mantener abierta la miotomía. Se recomienda la calibración mediante un tutor para que la funduplicatura no quede ni muy apretada, que produciría disfagia y Síndrome de "Gas Bloat" (no pueden eructar ni vomitar), ni muy laxa, en la que volvería aparecer el RGE. El abordaje laparoscópico es el de elección en la actualidad, salvo que existan contraindicaciones. La gastroplastia de Collis es un procedimiento consistente en alargar el esófago intraabdominal a expensas de crear un tubo con la curvatura menor gástrica con división y sutura de su pared. Se indica cuando no es posible una funduplicatura sin tensión como, por ejemplo, ante un esófago corto.

-----o-----

Cada vez son más frecuentes los procedimientos que se realizan a través de un abordaje laparoscópico; para ello debemos inducir un neumoperitoneo mediante la insuflación con gas de la cavidad abdominal. El gas de elección para realizar dicha técnica debe tener las siguientes características, EXCEPTO:

1. No irritante.
2. Incomburente o no inflamable.
3. Transparente.
4. Pobre capacidad de difusión.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Las características que debe reunir un “buen gas” para ser utilizado como inductor de neumoperitoneo en una laparoscopia son deducibles a través de la lógica. Por un lado, debe ser inerte, y poder encontrarse en la naturaleza, no irritar ni el contenido intraabdominal ni al personal de quirófano (el gas debe salir tras la intervención). No debe inflamarse ni producir combustión, ya que es preciso recordar que usamos bisturí eléctrico. Debe ser transparente para poder ver bien, y lo más soluble posible para que no permanezca mucho tiempo en el paciente, ya que le produce molestias. El gas ideal es el CO₂, aunque otros como el óxido nitroso, también se han empleado. El CO₂(gas ideal), tiene una elevada capacidad de difusión (opción 4 falsa, por lo que la marcamos).

-----O-----

En relación con las enfermedades del ano, indique la afirmación INCORRECTA:

1. Las hemorroides internas suelen ser dolorosas sin necesidad de complicación.
2. La ligadura de hemorroides es útil en el tratamiento de las hemorroides internas.
3. El dolor con la defecación debe hacer pensar en fisura anal o úlcera.
4. Las hemorroides externas pueden causar dolor con más frecuencia por trombosis.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Las hemorroides internas están producidas por la dilatación del plexo hemorroidal interno constituido por la vena rectal superior y media, que se encuentran en el espacio submucoso superiores a la válvula de Morgagni. Su manifestación más frecuente es la rectorragia. El dolor es menos frecuente, para que este exista debe haber alguna complicación. La ligadura es útil en los grados más leves de hemorroides internas. La externas si causan dolor a menudo porque la trombosis es más frecuente.

-----O-----

Son factores pronósticos del cáncer colorrectal todos los siguientes excepto:

1. Clasificación TNM
2. CEA
3. Variante histológica con amplio componente mucinoso
4. Localización en colon izquierdo

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Las variantes histológicas desfavorables, el grado de infiltración (referido por el TNM) la presentación clínica complicada con obstrucción o perforación y un CEA elevado que refleja una importante carga tumoral forman parte de los factores de mal pronóstico del cáncer colorrectal . La localización en sí no es un factor de mal pronóstico aunque variantes con peor pronóstico se han asociado más a la localización derecha.

-----O-----

Paciente que, tras una sobrecarga alcohólica, presenta vómitos copiosos y, varias horas después, intenso dolor precordial, enfisema subcutáneo y, en Rx de tórax, derrame pleural izquierdo. ¿Qué proceso le sugiere?

1. Pericarditis aguda.
2. Neumonía aspirativa.
3. Neumotórax espontáneo.

4. Rotura espontánea de esófago.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Caso clínico sobre un síndrome de Boerhaave, que no es otra cosa que una perforación esofágica relacionada con vómitos, normalmente en el contexto de un paciente bebedor. La presencia de enfisema subcutáneo es muy indicativa de que puede haberse producido esta complicación (respuesta 4 correcta).

-----O-----

Hombre de 36 años remitido a la consulta de Cirugía tras drenaje urgente de absceso perianal dos meses antes, persistiendo supuración. El paciente estaba siendo estudiado previamente por digestivo por cuadro de diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso. Colonoscopia: recto de aspecto normal; a nivel de colon descendente y sigma se alternan zonas con aspecto de “empedrado” y úlceras lineales y profundas con otras de aspecto normal. Se completa estudio con Eco endoanal y RM, observándose una fístula transesfinteriana alta. Sin tratamiento médico actual. ¿Cuál sería el tratamiento inicial MÁS adecuado de la fístula?

1. Fistulotomía.
2. Colocación de sedal no cortante en el trayecto de la fístula asociado a tratamiento con metronidazol, infliximab e inmunosupresores.
3. Realizar drenajes repetidos cada vez que presente un absceso, asociando tratamiento con infliximab e inmunosupresores.
4. Esfinterotomía lateral interna.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta en la que nos piden contestar cómo debemos actuar quirúrgicamente ante una enfermedad perianal en el contexto de una Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Nos describen a un paciente joven en estudio por diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso con una descripción endoscópica sugestiva de enfermedad inflamatoria intestinal (mucosa en empedrado y úlceras lineales y profundas). Además, el paciente tiene una fístula compleja (transesfinteriana alta) y episodios previos de absceso perianal. El papel de la cirugía en estos casos es el de drenar la sepsis perianal exclusivamente, es decir, drenar las cavidades abscesuales y mantener el drenaje permeable mediante la colocación de sedales (setones) para evitar nuevos abscesos. No olvidemos que el tratamiento de la enfermedad perianal de Crohn es el tratamiento médico sistémico, mediante metronidazol inicial y posteriormente inmunosupresores o antiTNF como el infliximab (respuesta 2 correcta). Dado que el paciente va a estar inmunosuprimido, es prioritario evitar nuevos episodios de abscesos, por lo que en ocasiones se mantiene el sedal a largo plazo (hasta conseguir remisión) o incluso de por vida.

-----O-----

Tras hacer la historia clínica y ordenar las pruebas complementarias, se llega al diagnóstico de que un paciente de 45 años tiene una apendicitis aguda sin peritonitis que requiere una apendicectomía urgente. El paciente le pregunta sobre la posibilidad de llevar a cabo la intervención por laparoscopia. Su contestación es:

1. La cirugía laparoscópica sólo está indicada para la colecistectomía.

2. La apendicitis aguda sin peritonitis puede tratarse por laparoscopia y puede ofrecer algunas ventajas sobre la laparotomía.
3. La apendicitis aguda es una contraindicación absoluta para el abordaje laparoscópico.
4. La única indicación de cirugía laparoscópica es el plastrón inflamatorio palpable en fosa iliaca derecha.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Un paciente muy versado en cirugía general, por lo que parece. La verdad es que no le falta razón al plantearle a su médico la posibilidad de un tratamiento por laparoscopia. Esta técnica ha revolucionado la cirugía y, hoy día, está universalmente reconocida como un avance fundamental, habiéndose demostrado en bastantes patologías beneficios muy claros frente al abordaje clásico.

Los beneficios de la laparoscopia sobre la cirugía convencional son, entre otros:

- Menor agresión quirúrgica, lo que disminuye la inflamación, el dolor postoperatorio y la posibilidad de íleo paralítico. La recuperación será, en consecuencia, más rápida y la estancia hospitalaria será menor.
- Menos adherencias intraabdominales.
- Menor inmunodepresión perioperatoria.
- Amplia visión del campo quirúrgico, mejor que la cirugía abierta, sobre todo cuando existe obesidad.
- Mayor satisfacción estética (menor cicatriz).

En algunas situaciones, el abordaje laparoscópico se considera de primera elección, como en la cirugía de la acalasia, en la colecistectomía, al realizarse funduplicaturas por reflujo gastroesofágico o para realizar ligaduras tubáricas. En el caso de la apendicitis aguda, su uso ya está ampliamente aceptado, por lo que puede beneficiarse de las ventajas antes enumeradas (respuesta 3 correcta). No obstante, en caso de tratarse de una situación de extrema urgencia, que no es el caso, no podría utilizarse y sería preferible la cirugía abierta.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes NO se considera una complicación general del acceso laparoscópico en cirugía abdominal?

1. Hemorragia de órganos sólidos.
2. Íleo paralítico.
3. Hernia en los orificios de acceso abdominal.
4. Neumomediastino.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La laparoscopia ha revolucionado la cirugía. La realización de pequeñas incisiones en el abdomen permite llevar a cabo las mismas técnicas quirúrgicas que se hacen en cirugía abierta, con una visualización y manipulación óptimas. Los beneficios de la laparoscopia son muchos, pero también presenta algún inconveniente. Debido a la menor agresión quirúrgica, menor reacción inflamatoria, menor dolor postoperatorio y menor número de adherencias postquirúrgicas, disminuye la tasa de íleo paralítico y se produce una rápida recuperación (marcamos la opción de respuesta 2). El abordaje laparoscópico mediante

aguja de Veres o trócares ópticos puede ocasionar hemorragia. Del mismo modo, la insuflación en el espacio preperitoneal durante el abordaje puede ascender hasta el mediastino generando neumomediastino. Las heridas en la pared abdominal que dejan los puertos en ocasiones no se cierran con sutura y pueden desarrollar hernias.

-----O-----

Mujer de 56 años con dolores abdominales en hipocondrio derecho recidivantes en los últimos meses. Ha perdido peso porque vomita todo lo que contiene algo de grasa. Mientras espera el estudio que se ha solicitado, acude por ictericia. La causa más probable será:

1. Cáncer de vesícula
2. Cáncer de la cabeza de páncreas
3. Colédocolitiasis
4. Cólecistitis aguda

Resp. Correcta: 3

Comentario: La ictericia en pacientes con antecedentes de dolores cólicos en HD debe hacernos sospechar colédocolitiasis, mientras que la ictericia indolora progresiva se asocia a neoplasia periampular

-----O-----

Una de las siguientes no es una ventaja de la colecistectomía laparoscópica sobre la colecistectomía laparotómica:

1. Menor dolor postoperatorio
2. Menor estancia hospitalaria
3. Menor lesión de vía biliar
4. Menor complicación de las heridas quirúrgicas

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El abordaje mínimamente invasivo implica incisiones más pequeñas que se traduce en menor dolor, mejor recuperación funcional, menor complicación de las heridas quirúrgicas, traducándose todo esto en menor estancia hospitalaria. Sin embargo, La lesión iatrogénica de la vía biliar no es inferior en el abordaje laparoscópico, siendo incluso superior en algunas series publicadas.

-----O-----

Un hombre de 35 años acude a Urgencias con dolor perianal intenso y fiebre de 38 °C de dos días de evolución. En la exploración presenta una masa dolorosa en fosa isquio-rectal izquierda. ¿Cuál es la actitud MÁS adecuada?

1. Antibióticos de amplio espectro y controlar evolución.
2. Realizar ecoendoscopia y PAAF ecoguiada.
3. Drenaje bajo anestesia regional.
4. Realizar una TC y así valorar la vía de abordaje para su correcto tratamiento.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El caso nos presenta un paciente con síntomas y signos muy sugestivos de absceso perianal de localización isquirrectal. Presenta dolor anal intenso y fiebre así como masa dolorosa en fosa isquirrectal. Esto en un paciente de 35 años sin AP de interés debemos pensar en lo más frecuente, que será un absceso isquirrectal. El tratamiento de los abscesos es el drenaje quirúrgico dejando la herida abierta para su cicatrización por segunda intención. Los Antibióticos solamente estarán indicados en situaciones especiales (respuesta 1 falsa). La realización de TAC es necesaria en abscesos ocultos que pueden tener su origen supraelevador o en abscesos postanales, cuando la sospecha es clínica pero no se objetiva absceso en la exploración física (respuesta 4 falsa). La ecografía endorrectal o ecoendoscopia es una exploración limitada por el dolor y se utiliza casi exclusivamente para localizar intraoperatoriamente abscesos ocultos. La respuesta 2 es falsa porque la realización de PAAF hace pensar que se realiza para diagnóstico de la masa, que es inflamatoria en este caso y no tumoral.

-----O-----

Señale lo correcto con respecto a los divertículos esofágicos:

1. La disfagia paradójica es característica de los divertículos epifrénicos.
2. Los divertículos de Zenker suelen ser asintomáticos.
3. Los divertículos medioesofágicos suelen estar relacionados con procesos inflamatorios mediastínicos.
4. Los divertículos epifrénicos surgen por el triángulo de Killian.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La disfagia paradójica es la que se produce en algunas disfagias de tipo motor incipiente, que se expresan únicamente con disfagia para alimentos líquidos. Los divertículos de Zenker aparecen en hipofaringe posterior y presenta clínica de disfagia en relación con la asociación de trastornos motores del cricofaríngeo y, por tanto, en forma independiente al tamaño de los mismos. Los divertículos del tercio medio del esófago suelen estar relacionados con procesos inflamatorios o adenopatías que por tracción inducen dichas alteraciones.

-----O-----

En el tratamiento del cáncer colorrectal no es cierto :

1. La capa mural del colon que limita la posibilidad de invasión linfática y capacidad de metastatizar a ganglios regionales es la muscular.
2. Los tumores de recto localmente avanzados precisan tratamiento neoadyuvante con quimiorradioterapia
3. El tratamiento de un paciente con cáncer de colon derecho y múltiples metástasis hepáticas es quimioterápico pudiendo asociar un régimen de quimioterapia (FOLFOX ó FOLFIRI) a un anticuerpo monoclonal.
4. Las metástasis hepáticas de cáncer colorrectal pueden ser tratadas con quimioterapia para intentar posteriormente realizar un rescate quirúrgico

Resp. Correcta: 1

Comentario: La infiltración de la muscular de la mucosa (muscularis mucosae) otorga a los tumores colorrectales la capacidad de metastatizar.

-----O-----

El reflujo gastroesofágico crónico se asocia con:

1. Infección por H.Pylori de la mucosa gástrica
2. Hernia de hiato
3. Esófago de Barret
4. Divertículos esofágicos

Resp. Correcta: 3

Comentario: El esófago de Barret esta asociado a la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

-----o-----

En relación con la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía robótica, señale la respuesta más correcta:

1. El sistema Da Vinci es completamente manual y analógico, sin intervención de la informática
2. El cirujano que maneja el sistema tiene visión bidimensional
3. El ayudante controla los instrumentos mediante las órdenes verbales del cirujano principal
4. La tecnología robótica digitaliza los movimientos y reduce el temblor, reproduciendo los gestos en tiempo real

Resp. Correcta: 4

Comentario: El sistema Da Vinci® consiste en una cirugía robotizada y asistida por ordenador, que permite al cirujano principal realizar la intervención desde una consola a distancia con un sistema óptico tridimensional y dos controles manuales.

-----o-----

En relación a la colecistitis alitiásica es falso:

1. Se relaciona con pacientes críticos
2. Su agente etiopatogénico es el Clostridium
3. La nutrición parenteral prolongada y el ayuno puede desencadenarla
4. Se da en un 10% de los pacientes con colecistitis agudas

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La colecistitis alitiásica es una entidad típica de pacientes críticos en UCI o grandes quemados con enfermedades sistémicas que sufren una isquemia a nivel de la vesícula. El ayuno prolongado puede precipitar su aparición siendo su incidencia estimada en un 10% de los pacientes con colecistitis aguda. El Clostridium , germen anaeróbico productor de gas es el causante de las colecistitis enfisematosas.

-----o-----

Señale la respuesta FALSA sobre el síndrome de Boerhaave o rotura esofágica espontánea:

1. El síntoma más frecuente es el dolor.
2. En su mecanismo de producción se valora como causa esencial el aumento brusco y repentino de la presión intraesofágica producido por los vómitos.
3. La rotura se produce típicamente en el esófago cervical.
4. Uno de los aspectos más importantes de su tratamiento es asegurar un buen drenaje del mediastino,

para evitar la aparición de mediastinitis.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Este síndrome suele producirse después de vómitos repetidos. Cursa generalmente con intenso dolor esternal y suele complicarse con mediastinitis, salvo que se coloque un buen drenaje a nivel mediastínico. La ruptura generalmente es en el esófago medio o distal y es más frecuente en pacientes con antecedente de alcoholismo.

-----O-----

El tratamiento farmacológico más eficaz del síndrome de Zollinger-Ellison incluye:

1. Hidróxido de aluminio.
2. Inhibidores de la bomba de protones.
3. Carbonato cálcico.
4. Bicarbonato sódico.

Resp. Correcta: 2

Comentario: En el síndrome de Zollinger- Ellison (gastrinoma), el tratamiento médico es paliativo. Para aliviar los síntomas, los fármacos más eficaces son los inhibidores de la bomba de protones, a dosis altas. El resto de grupos farmacológicos no se han mostrado eficaces. Pero el tratamiento de elección de este síndrome es la extirpación quirúrgica del tumor, que tiene una gran tendencia a la diseminación.

-----O-----

Mujer de 80 años con DM conocida que presenta cuadro de diarrea con sangre de varios días de evolución que atribuyó a las hemorroides. Ahora es traída a urgencias en shock con irritación peritoneal generalizada. Su actitud será:

1. Colonoscopia urgente
2. TAC urgente
3. Arteriografía urgente
4. Laparotomía urgente

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Ante un paciente con abdomen agudo debemos plantearnos si el paciente está estable o inestable, si está grave o no lo está.

Si un paciente está estable, sin datos de gravedad clínica, debemos investigar la causa y hacer el diagnóstico diferencial. Pero si está grave debemos proceder a la cirugía urgente.

-----O-----

Varón de 60 años, acude a consulta con cuadro de halitosis y regurgitación de saliva y partículas de alimento consumidos varios días antes. Tiene antecedentes de procesos bronconeumónicos de repetición y crisis de tos con la deglución. ¿Ante qué proceso patológico nos encontramos con MAYOR probabilidad?

1. Divertículo de Zenker.

2. Anillo de Schatzki.
3. Adenocarcinoma de esófago.
4. Acalasia esofágica.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El divertículo de Zenker (respuesta 1 correcta) se localiza en la parte posterior de la hipofaringe, por encima del músculo cricofaríngeo y debajo del músculo constrictor inferior de la faringe. Los divertículos de Zenker se originan por pulsión, debido a una mala coordinación de la musculatura faríngea. Puede causar halitosis, regurgitación, disfagia orofaríngea e incluso una obstrucción completa por compresión. Como complicaciones, puede producir episodios de broncoaspiración, formación de fistulas entre el divertículo y la tráquea, hemorragia intradiverticular (sobre todo con la aspirina) y, más raramente, la aparición de un carcinoma epidermoide dentro del divertículo. La colocación de una sonda nasogástrica o la realización de una endoscopia en estos pacientes tiene riesgo de perforación del divertículo, por lo que deben evitarse. El tratamiento es quirúrgico, realizándose una miotomía cricofaríngea y extirpando el divertículo. Si es pequeño, la miotomía aislada puede ser suficiente.

-----O-----

¿En cuál de las siguientes circunstancias aplicaría de entrada mesilato de imatinib en un tumor GIST?

1. Tumor metastático.
2. Tumor con bajo índice mitótico.
3. Tumor con riesgo alto de malignidad.
4. Tumor resecable de 8 cm de diámetro.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El mesilato de imatinib (STI571) es un fármaco que inhibe la tirosinquinasa del receptor c-kit, enzima implicada en la patogénesis de los tumores estromales gastrointestinales. Diferentes estudios muestran que el tratamiento con imatinib ofrece buenos resultados como tratamiento neoadyuvante, mejorando la respuesta en estadios avanzados de la enfermedad con tumores irresecables o metastásicos, y en muchos casos permite la cirugía de rescate posterior, único tratamiento curativo. Además, también está indicado en la aparición de metástasis metacrónicas y en casos de ruptura tumoral durante la exéresis de la lesión.

-----O-----

Paciente que sufre un episodio de pancreatitis aguda, pero que, tras varios días de tratamiento médico, persiste con fiebre, dolor abdominal e íleo paralítico junto con elevación discreta y sostenida de la cifra de amilasa sérica. Se le realiza una ecografía abdominal en la que se observa un pseudoquiste pancreático de 5 cm de diámetro. Señale la afirmación INCORRECTA con respecto a su tratamiento:

1. Si el estado general del paciente es satisfactorio, deberá observarse durante 4-6 semanas y, si en este período el pseudoquiste ha crecido, se decidirá la intervención quirúrgica.
2. Cuando un pseudoquiste grande se localiza en la cabeza del páncreas, el tratamiento quirúrgico de elección es la cistoduodenostomía transduodenal.
3. Si el paciente presenta fiebre mantenida de 38 °C en el momento del diagnóstico, está indicada la

cirugía urgente del pseudoquiste, ya que esto invariablemente implica que está infectado.

4. En los casos de ascitis pancreática, el drenaje interno del pseudoquiste resulta un método curativo.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los pseudoquistes son formaciones de contenido líquido no recubiertas del epitelio de los conductos pancreáticos, que tampoco tienen una cápsula propiamente dicha y que se producen por el acúmulo de secreciones pancreáticas tras agresiones diversas en el seno del tejido pancreático, en su mayoría por pancreatitis. Esta pregunta es relativamente sencilla, aunque no sepas demasiado sobre el manejo del pseudoquiste pancreático. La opción de respuesta 3 es muy restrictiva al decir que la fiebre, INVARIABLEMENTE, traduce una infección del pseudoquiste. En un paciente encamado podríamos encontrar otras muchas razones por las que pueda aparecer fiebre: atelectasias, infecciones urinarias, neumonías nosocomiales, fiebre medicamentosa, etc. Además, en el tratamiento quirúrgico del pseudoquiste debes tener claro que no se extirpan (salvo en la cola, donde se reseca junto con el páncreas distal), sino que se derivan al intestino; y que nunca puede manejarse mediante cirugía antes de 6 semanas de su formación.

-----O-----

Señale la INCORRECTA en relación al síndrome de Mallory-Weiss:

1. Suelen dejar de sangrar espontáneamente.
2. El desgarro se localiza con más frecuencia en el esófago medio.
3. Es raro que se necesite cirugía.
4. La vasopresina intraarterial puede ser útil.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El síndrome de Mallory- Weiss se produce como consecuencia de una erosión o desgarro de la mucosa esofágica distal de forma secundaria a vómitos de repetición. La expresión clínica suele ser el sangrado digestivo, casi siempre en forma de hematemesis. Habitualmente cesa de forma espontánea y raramente requiere cirugía o administración intraarterial de sustancias vasoactivas. Suele asociarse a alcoholismo crónico.

-----O-----

Paciente varón de 45 años en seguimiento por esófago de Barret con displasia leve. En una endoscopia de control se objetiva una pequeña lesión tumoral en esófago abdominal de 0,5 cm compatible con adenocarcinoma de esófago. En el estudio de extensión mediante eco endoscopia se observa que la lesión no traspasa la submucosa y no presenta adenopatías ni metástasis en el TAC. Indique la actitud terapéutica que se podría adoptar con este paciente:

1. Quimioterapia neoadyuvante.
2. Radioquimioterapia neoadyuvante.
3. Cirugía radical: gastrectomía.
4. Es preciso individualizar el tratamiento en función de las características del paciente, pudiéndose optar entre cirugía o técnicas ablativas.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El tratamiento de los tumores resecables de esófago se puede resumir de la siguiente manera:

Estadios precoces (T1-T2, N0): cirugía inicial: esofagectomía.

Es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Tis o T1a (que no invaden la submucosa) pueden ser candidatos a resección mucosa endoscópica, otras técnicas ablativas o esofagectomía. En la elección del tratamiento es preciso determinar la existencia de multifocalidad y el grado histológico.
- T1b y T2: el tratamiento estándar es la esofagectomía. En más de la mitad de los casos de T2 la pieza final revela adenopatías + (mal estadificación inicial), lo que obliga a dar quimioterapia adyuvante.

Estadios avanzados (T3, T4a, N+). El tratamiento estándar es: neoadyuvancia con quimio (QT)-radioterapia (RT) con el objetivo de reducir masa tumoral e intentar después una cirugía radical.

Por tanto estos tumores precoces pueden ser candidatos a tratamiento local en función de las características histológicas del tumor y el riesgo quirúrgico y deseos del paciente.

-----O-----

Una paciente de 31 años acude por presentar dolor en fosa ilíaca derecha. No tiene fiebre ni otros síntomas. Tiene irritación peritoneal a la palpación en fosa ilíaca derecha y en hipogastrio. La analítica sanguínea es normal. Usted se inclinaría por todas menos una de las siguientes opciones. Señale la falsa:

1. Laparotomía urgente
2. Exploración ginecológica
3. Ecografía abdominal
4. Observación y vigilancia con nueva exploración y analítica

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Ante un paciente con abdomen agudo debemos plantearnos si el paciente está estable o inestable, si está grave o no lo está.

Si un paciente está estable, sin datos de gravedad clínica, debemos investigar la causa y hacer el diagnóstico diferencial. Pero si está grave debemos proceder a la cirugía urgente.

-----O-----

Según la clasificación del grado de prolapso hemorroidal, las hemorroides que no se pueden reducir se denominan:

1. Grado 2
2. Grado 3
3. Grado 4
4. Grado 5

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Recuerda la clasificación de las hemorroides internas:

Grado 1: no prolapsadas

Grado 2: Prolapso con el esfuerzo, se reduce espontáneamente.

Grado 3: Prolapso con el esfuerzo, se reduce manualmente.

Grado 4: prolapso irreductible, permanente

-----O-----

Un paciente de 20 años ha sufrido una agresión con arma blanca en el abdomen, presentando un orificio en la piel en el hipocondrio izquierdo. A su llegada a Urgencias se encuentra consciente, la auscultación pulmonar es normal y presenta una tensión arterial de 120/70 mmHg con 80 latidos por minuto. Decidimos explorar la herida apreciándose que el trayecto llega al plano muscular, pero sin llegar a determinar si la herida penetra o no en peritoneo. Diga cuál cree que NO es una opción correcta a continuación:

1. Hacer un TC abdominal con contraste.
2. Laparoscopia exploradora.
3. Vigilancia intensiva y exploración abdominal continuada para detectar signos de peritonismo precozmente.
4. Hacer arteriografía urgente para descartar lesión vascular intraabdominal.

Resp. Correcta: 4

Comentario: En esta circunstancia, con paciente estable y la duda de si la herida es penetrante o no, podemos optar por una de las tres primeras respuestas. No está indicada la arteriografía en este caso, dada la estabilidad y que no existe sospecha de sangrado

-----O-----

La técnica POEM es una técnica de tratamiento endoscópico de una de las siguientes patologías. Señálela:

1. Enfermedad por reflujo gastroesofágico.
2. Acalasia.
3. Divertículo de Zenker.
4. Cáncer de esófago distal.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre la miotomía endoscópica por vía oral (POEM), procedimiento realizado bajo anestesia general en el que, a través de un abordaje endoscópico, se seccionan de forma selectiva fibras musculares de la unión gastroesofágica. El POEM es una técnica de tratamiento endoscópico utilizada en la acalasia (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Señale la respuesta incorrecta sobre la patología biliar benigna :

1. El único tratamiento eficaz para la colelitiasis sintomática es la colecistectomía.
2. Nunca está indicada la cirugía profiláctica de la vesícula si la colelitiasis es asintomática.
3. La mayor parte de las ictericias obstructivas son benignas y su causa principal es la coledocolitiasis, cuyo tratamiento es la esfinterotomía endoscópica.
4. Ante un paciente con aerobilia y obstrucción intestinal , debemos pensar en una fistula colecisto-entérica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Existen unas indicaciones de colecistectomía en colelitiasis asintomática como son: presencia de cálculos mayores de 2,5 cm o microlitiasis, niños y adolescentes, anemia hemolítica, cirugía de la obesidad y situaciones de inmunosupresión.

Además en caso de lesiones potencialmente malignas como la vesícula en porcelana o los pólipos vesiculares

-----O-----

Con respecto a la perforación esofágica, señale la afirmación CORRECTA:

1. El síndrome de Boerhaave es la causa más frecuente de perforación esofágica.
2. El síntoma más común tras una perforación es el dolor.
3. El estudio gastroduodenal baritado es de elección para el diagnóstico.
4. Los pacientes inestables con perforación de más de 24 horas de evolución y presencia de mediastinitis son candidatos a esofagectomía.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La causa más frecuente de perforación esofágica es la iatrogénica. El síntoma más común tras una perforación es el dolor (respuesta 2 correcta). Los contrastes hidrosolubles son de elección para el diagnóstico de rotura esofágica. Los pacientes estables, con perforación pequeña reciente y sin signos de sepsis, son candidatos a tratamiento conservador. Los pacientes inestables con gran contaminación deben ser sometidos a drenaje quirúrgico y valorar la exclusión esofágica. La esofagectomía urgente puede ser una opción en pacientes estables con esófago patológico.

-----O-----

Señale la correcta respecto al cáncer de vesícula:

1. Es más frecuente en varones ancianos.
2. La tomografía computarizada (TC) representa la prueba más habitual para el estudio de extensión.
3. Se asocia a ictericia e incremento del CEA (antígeno carcinoembrionario).
4. Su tratamiento curativo consiste en hepatectomía derecha y linfadenectomía perivesicular.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El cancer de vesicula se diagnostica y estadifica mediante TAC. El tratamiento es la colecistectomia con hepatectomia del segmento IVb y V así como linfadenectomia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al divertículo faringoesofágico o divertículo de Zenker?:

1. Se trata de un divertículo por tracción.
2. Suele diagnosticarse en pacientes jóvenes.
3. El tratamiento incluye la miotomía del músculo cricofaríngeo.
4. Se localiza siempre en la cara anterior de la hipofaringe.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El divertículo de Zenker se localiza en la parte posterior de la hipofaringe, por encima del músculo cricofaríngeo y debajo del músculo constrictor inferior de la faringe. Se originan por pulsión, debido a una mala coordinación de la musculatura faríngea. Puede causar halitosis, regurgitación, disfagia orofaríngea e incluso una obstrucción completa por compresión.

Como complicaciones, puede producir episodios de broncoaspiración, formación de fistulas entre el divertículo y la tráquea, hemorragia intradiverticular (sobre todo con la aspirina) y, más raramente, la aparición de un carcinoma epidermoide dentro del divertículo. La colocación de una sonda nasogástrica o la realización de una endoscopia en estos pacientes tiene riesgo de perforación del divertículo, por lo que deben evitarse. El tratamiento es quirúrgico, realizando una **miotomía cricofaríngea** y extirpando el divertículo. Si es pequeño, la miotomía aislada puede ser suficiente.

Mujer de 65 años sin antecedentes personales de interés, intervenida de adenocarcinoma de sigma que infiltra la serosa (T4) con afectación de 2 ganglios de 35 aislados (N1). En el estudio de extensión no se evidencian metástasis a distancia (M0). ¿Cuál es el siguiente paso a realizar?

1. Determinar mutación de KRAS y NRAS para poder administrar un anti-EFGR en caso de no ser mutado.
2. Asociar al tratamiento con quimioterapia bevacizumab en caso de ser mutado.
3. Administrar una combinación de quimioterapia con fluorouracilo y oxaliplatino.
4. Realizar tratamiento con radioterapia al tener afectación ganglionar.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Esta pregunta hace referencia a la necesidad de adyuvancia en una paciente con cáncer de colon estadio III (es un N+). La adyuvancia del cáncer de colon con quimioterapia, ha demostrado aumentar la supervivencia tras la cirugía en los pacientes con tumores estadio III. Sin embargo, la radioterapia, no ha demostrado este beneficio por lo que la respuesta 4 es incorrecta. Los fármacos más utilizados en adyuvancia del cáncer de colon son el 5-fluorouracilo (5-FU) y la capecitabina (fluoropiridina que se administra por vía oral) habitualmente asociados a leucovorin u oxaliplatino. La respuesta 3 se ajusta a estas combinaciones por lo que la consideramos correcta. Las terapias dirigidas contra anticuerpos monoclonales como bevacizumab (contra el VEGF) o cetuximab (contra EGFR) en combinación con los quimioterápicos

anteriores, no son consideradas inicialmente como un tratamiento estándar en adyuvancia de cáncer de colon (respuestas 1 y 2 incorrectas), usándose en situaciones individualizadas (segundas líneas de tratamiento, metástasis...).

-----o-----

No es cierto en la ictericia obstructiva :

1. El prurito, la acolia y la coluria es la clínica típica de la colestasis, siendo su patrón bioquímico la elevación de bilirrubina directa, FA, GGT, LDH con o sin alteración de transaminasas.
2. La ecografía es la primera prueba de imagen a realizar en un paciente con ictericia.
3. La CPRE es una prueba endoscópica inocua con la ventaja de ser terapéutica.
4. El tumor de Klastkin provoca dilatatación de vía biliar intrahepática.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La ictericia obstructiva se manifiesta como describe la respuesta 1 y la prueba de elección de entrada es la Eco. La CPRE es una prueba invasiva con riesgos de complicaciones (los más graves la pancreatitis, hemorragia y perforación).

El tumor de Klatskin es un tumor de la bifurcación de los conductos hepáticos por lo que dilata la vía intra pero no la extrahepática.

-----o-----

Mujer de 45 años, de profesión secretaria, fumadora de 1,5 paquetes de cigarrillos/día que refiere hemorroides que sangran frecuentemente con la deposición y que prolapsan fuera del canal anal, siendo dificultosa su reducción. También refiere prurito anal y dolor ligero en la zona perianal. A la vista de lo anterior, ¿qué tratamiento indicaría?

1. Dieta rica en fibra + laxantes.
2. Esclerosis endoscópica.
3. Cirugía hemorroidal.
4. Ninguno.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El caso que nos describen corresponde a unas hemorroides grado IV. Recuerda que el grado III consiste en que solamente prolapsan cuando el paciente puja, pero se reducen manualmente de forma completa. Sin embargo, el enunciado nos especifica que la reducción es dificultosa, es decir, estamos pasando de un grado III a un IV. El tratamiento de las hemorroides de grado IV consiste en la cirugía hemorroidal.

-----o-----

Señale la respuesta falsa respecto a la cirugía mínimamente invasiva:

1. Cardiopatías, coagulopatías, EPOC y cirugías abdominales previas son consideradas contraindicaciones relativas para realizar una cirugía laparoscópica
2. La cirugía laparoscópica por puerto único y el NOTES han supuesto una revolución en el campo de la cirugía mínimamente invasiva demostrando una clara mejoría sobre la cirugía laparoscópica

convencional

3. La cirugía robótica consiste en una cirugía asistida por un ordenador, con un sistema óptico tridimensional en el cual se digitalizan los movimientos de la mano del cirujano en tiempo real
4. La cirugía endoscópica transluminal por orificios naturales (NOTES) consiste en el acceso a la cavidad peritoneal a través de algún orificio natural, ya sea tubo digestivo, vagina o vejiga y realizar la intervención quirúrgica mediante un endoscopio flexible

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre aspectos actuales de la cirugía mínimamente invasiva, debemos señalar la falsa y en este caso corresponde a la respuesta número 2, puesto que debemos saber que el puerto único y el NOTES no han demostrado diferencias respecto a la laparoscopia tradicional, son abordajes más caros, más difíciles técnicamente y por ello su difusión e implementación ha sido bastante pobre, en ningún caso sustituyen a la laparoscopia sino que la complementan

-----O-----

Respecto a la cirugía de las complicaciones de la coledolitiasis, y en concreto la coledocolitiasis, señale la respuesta NO correcta:

1. Las imágenes de la colangioRMN son tan buenas como las de la CPRE
2. La complicación más frecuente de la coledocolitiasis es la cirrosis biliar secundaria
3. Ante un paciente con coledolitiasis y coledocolitiasis, la opción más aceptada es CPRE más colecistectomía posterior
4. Una de las opciones para extraer los cálculos durante la cirugía es la derivación bilioentérica

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La coledocolitiasis se presenta de forma relativamente frecuente en aquellos pacientes que presentan cálculos en la vesícula biliar. Estos cálculos en el colédoco, pueden cursar asintomáticos o producir:

- cólico biliar
- ictericia obstructiva
- colangitis ascendente
- pancreatitis

La cirrosis biliar secundaria es una complicación poco común (por lo tanto, respuesta NO correcta y a marcar, la 2). Es importante que pensemos en coledocolitiasis cuando nos enfrentemos a un paciente con elevación de bilirrubina a expensas de la fracción directa y esté colecistectomizado.

La primera prueba de imagen será la ecografía, y en función de los resultados de la misma el paciente precisará colangioRMN o CPRE (ésta última si el diagnóstico ecográfico es seguro). Parece bastante evidente en el momento actual que el paciente con coledocolitiasis se beneficia de realizar en primera instancia una CPRE y cuando se haya resuelto el problema en la vía biliar, realizar la colecistectomía.

En los casos, pocos, que la CPRE no pueda solucionar el problema la extracción del cálculo debe ser quirúrgica: a través del cístico, del colédoco o muy excepcionalmente con una derivación bilioentérica.

Paciente mujer de 55 años, con antecedentes personales de HTA, DM2, esclerodermia e intervenida de cáncer de tiroides que acude a consulta con sintomatología de pirosis, regurgitaciones y laringitis crónica, pese a tratamiento médico con IBP a dosis máxima ¿Cual de los siguientes tratamientos es correcto?

1. Funduplicatura de Nissen
2. Continuar con tratamiento médico, no tiene indicación quirúrgica.
3. Funduplicatura de Toupet
4. Miotomía de Heller

Resp. Correcta: 3

Comentario: Entre sus antecedentes personales destaca la esclerodermia, una enfermedad degenerativa del tejido conjuntivo que afecta a la motilidad esofágica y por ello estaría indicado realizar una funduplicatura de 270 grados (Toupet) en vez de 360° (Nissen).

Entre las complicaciones propias de la pancreatitis aguda, NO se encuentra:

1. Pseudoquiste pancreático.
2. Derrame pleural.
3. Shock.
4. Calcificaciones pancreáticas.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La presencia de calcificaciones pancreáticas en las radiografías de abdomen de un paciente con clínica compatible con pancreatitis crónica (antecedentes de abuso del alcohol con dolor abdominal epigástrico bien crónico o recurrente) se produce en el 32 % de los casos y es patognomónico de pancreatitis crónica con una seguridad mayor del 95 %. El resto de las opciones enumeradas son complicaciones propias de las pancreatitis agudas.

Varón de 36 años, sin antecedentes personales de interés, diagnosticado de acalasia de cardias. El tratamiento de elección consiste en:

1. Miotomía endoscópica oral (POEM).
2. Dilatación neumática.
3. Miotomía laparoscópica de Heller.
4. Inyección intraesfinteriana de toxina botulínica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El tratamiento de elección de la acalasia es la miotomía laparoscópica de Heller (respuesta 3 correcta) con funduplicatura parcial para prevenir el reflujo. Debe ofrecerse siempre que exista un riesgo quirúrgico aceptable por su alta eficacia. Veamos las demás opciones de respuesta:

1.- El POEM realiza la miotomía por vía endoluminal sin asociar ninguna técnica antirreflujo, por lo que

este efecto secundario la hace de segunda elección, ya que aparece en aproximadamente la mitad de los casos.

2.- La dilatación se reserva para casos de fracaso tras la cirugía.

4.- La inyección intraesfinteriana de toxina botulínica y otros tratamientos farmacológicos como los calcioantagonistas o nitratos se emplean en pacientes de riesgo quirúrgico alto, con menor eficacia en el control de la acalasia que las técnicas quirúrgicas.

-----O-----
¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas es imprescindible realizar a un paciente que va a ser sometido a cirugía por ERGE?

1. Phmetría
2. Tránsito EGD (Esofagogastroduodenal)
3. Manometría esofágica
4. Endoscopia digestiva alta

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La endoscopia es la herramienta fundamental en el manejo del ERGE ya que permite categorizar adecuadamente la enfermedad, estableciendo los diferentes fenotipos que conllevan las distintas normas de manejo. El resto de pruebas funcionales (Phmetría , manometría y EGD) son recomendables pero no obligatorias

-----O-----
¿Cuál de los siguientes signos de irritación peritoneal es más específico de la apendicitis retrocecal?

1. Signo de Blumberg
2. Defensa involuntaria
3. Signo de Rovsing
4. Signo del psoas

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El signo de Blumberg o signo de rebote se puede presentar en cualquier caso de peritonitis al vibrar el peritoneo con la descompresión brusca.

El signo de Murphy es característico de la colecistitis aguda.

Los signos de Rovsing y del psoas son característicos de la apendicitis aguda, este último de la localización retrocecal.

-----O-----
Señale la afirmación FALSA, en relación con la resección laparoscópica del colon:

1. Casi todas las enfermedades del colon y recto, susceptibles de tratamiento quirúrgico, se pueden abordar mediante laparoscopia.
2. En la cirugía del cáncer de colon y recto, la disección ganglionar que se puede realizar por laparoscopia es más limitada que la efectuada por laparotomía.
3. El abordaje laparoscópico favorece un alta hospitalaria postoperatoria más precoz que tras una resección de colon convencional.
4. En la cirugía del cáncer de colon y recto, las tasas de supervivencia a largo plazo de los pacientes intervenidos por laparoscopia o laparotomía son similares.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Una pregunta difícil sobre la cirugía laparoscópica del colon. Para obtener una mayor perspectiva de lo que representa esta técnica, sus ventajas e inconvenientes, te recomendamos que revises la pregunta 12 de esta misma convocatoria (08- 09) y su comentario correspondiente. La encontrarás clasificada en el tema 20, por tratarse de una apendicitis aguda.

Una de las ventajas que ofrece la laparoscopia respecto al abordaje convencional es una visión más amplia del campo quirúrgico, sobre todo en pacientes obesos. Esto permite que la disección ganglionar que puede obtenerse no tenga por qué ser más limitada que a través de una laparotomía (respuesta 2 falsa).

-----O-----

Acude a tu consulta una mujer de 43 años sin antecedentes de interés, asintomática pero muy preocupada porque se realizó una endoscopia digestiva alta solicitada por su médico de cabecera, y en ella se objetiva una hernia de hiato por deslizamiento. ¿Cuál sería nuestra actitud?

1. Corresponde a una hernia de hiato tipo II, al ser asintomática no hay que hacer nada
2. Corresponde a una hernia de hiato tipo I, que no precisa tratamiento
3. Corresponde a una hernia de hiato tipo IV, estaría indicada la cirugía con reducción del saco herniario + Técnica antirreflujo (Nissen)
4. Corresponde a una hernia de hiato tipo III y precisa tratamiento quirúrgico

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta sobre manejo de las hernias de hiato, en este caso nos presentan una mujer asintomática con una hernia de hiato por deslizamiento que corresponde según la clasificación a un tipo I, en el que la UGE se desplaza al mediastino por el hiato, no presenta saco herniario y por lo general son asintomáticas, tan sólo precisan tratamiento quirúrgico cuando existen criterios de RGE sintomático. En cuanto al resto de respuestas la tipo II corresponde a los casos en los que el fundus se hernia por el hiato, las tipo III son mixtas y las tipo IV o complejas se deben a migración intratorácica de cualquier órgano abdominal

-----O-----

Las siguientes afirmaciones hacen referencia a diferentes aspectos anatómicos del esófago. Señale cuál de ellas considera CORRECTA:

1. La capa muscular está formada preferentemente de músculo estriado en su mitad inferior.
2. Un esófago normal mide menos de 20 cm de longitud.
3. El epitelio que lo recubre en condiciones normales es de tipo columnar salvo en la unión esofagogástrica.

4. El esófago carece de capa serosa.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El esófago carece de serosa. Este es uno de los motivos por los que los cánceres de esófago son tan agresivos, al no tener serosa que los contenga (respuesta 4 correcta). Repasemos las demás opciones de respuesta:

1.- La capa muscular es especialmente gruesa y consta de dos estratos: uno externo, de fibras longitudinales y otro interno, de fibras circulares, entre los que se dispone el plexo de Auerbach. Este músculo es de tipo estriado en el tercio proximal y liso en los dos tercios distales.

2.- El esófago es un tubo muscular de unos 25-30 cm de longitud que se extiende desde la faringe hasta el estómago.

3.- El epitelio del esófago es escamoso estratificado no queratinizado. En la unión esofagogástrica, el epitelio esofágico cambia bruscamente a un epitelio simple columnar característico del estómago. La presencia de epitelio columnar cubriendo el esófago distal debe considerarse patológica, especialmente si la biopsia muestra epitelio de tipo intestinal (esófago de Barrett).

-----o-----

Mujer de 67 años, obesa, que acude a Urgencias por dolor abdominal en cuadrante superior derecho del abdomen, fiebre de 39,5 °C y orinas muy oscuras. Ante este cuadro se debería sospechar en primer lugar:

1. Colecistitis aguda alitiásica.
2. Coledocolitiasis.
3. Colecistitis aguda litiásica.
4. Colangitis aguda.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Se trata de un caso clínico típico de colangitis aguda, con la clásica triada de Charcot, de ictericia, dolor y fiebre, aunque en este caso nos dan el dato de la coluria en lugar de la ictericia mucocutánea. En cualquier caso, la coluria es un dato de colestasis y el dolor y la fiebre datos de infección, lo que nos hace sospechar una colangitis como primera posibilidad.

-----o-----

Paciente de 7 años, que acude junto con sus padres a Urgencias presentando cuadro de dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha. Los días previos ha presentado un cuadro de infección respiratoria de vías altas que, en la actualidad, está en remisión. En la exploración abdominal presenta dolor en fosa ilíaca derecha, sin signos importantes de irritación peritoneal. En la analítica se evidencian 7.400 leucocitos con linfocitosis sin desviación izquierda. Con gran probabilidad, este paciente presenta un cuadro de:

1. Apendicitis aguda.
2. Invaginación intestinal.
3. Adenitis mesentérica.
4. Divertículo de Meckel.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La adenitis mesentérica es un cuadro mal definido; suele aparecer en los textos como parte diagnóstico diferencial de apendicitis aguda, pero pocas veces como un cuadro con entidad propia, como las demás enfermedades. Se caracteriza por dolor abdominal, muchas veces precedido por un cuadro respiratorio, lo que orienta a adenovirus o algún otro virus respiratorio como probable etiología. La presencia de compromiso general y fiebre alta también sugiere una etiología viral o bacteriana del cuadro. Por lo tanto, frente a un niño con dolor abdominal de comienzo brusco, que debuta con fiebre alta (39- 40 °C), no se debe pensar en una apendicitis aguda, sino en una adenitis mesentérica, más aún si el dolor es precedido o se acompaña de estos otros síntomas. El abdomen puede estar algo sensible difusamente, muchas veces en la fosa iliaca derecha, de manera que siempre se debe preguntar por los antecedentes, buscar otros síntomas asociados y efectuar un buen examen físico para no cometer un error. La ecografía, como todo examen de apoyo, es un elemento más que puede ser útil, pero el pilar diagnóstico en la apendicitis es la evolución. En general, cuando un niño tiene una adenitis mesentérica producida por un adenovirus o por otro virus, lo más probable es que con el paso de las horas no se agrave, pero sí puede persistir con fiebre y dolor abdominal. Si existen los antecedentes descritos y está más o menos claro que se trata de una adenitis mesentérica, se debe hacer un tratamiento conservador, que consiste principalmente en hidratar al paciente y dejarle en observación. No obstante, si algunas horas más tarde persiste la duda, se deberá ir a laparotomía exploratoria y se hará el diagnóstico intraoperatorio.

-----o-----

De los siguientes, ¿cuál se considera en la actualidad el aspecto más importante en la evaluación del abdomen agudo?

1. Realización de una anamnesis completa y exploración física minuciosa.
2. Valoración del hemograma, especialmente el recuento y fórmula leucocitarios.
3. Valoración de los resultados obtenidos en la ecografía de abdomen.
4. Valoración de los resultados obtenidos en el TC abdominal.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Pregunta muy sencilla sobre manejo del paciente con abdomen agudo. Antes que cualquier prueba complementaria, una anamnesis detallada con una buena exploración física es fundamental para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. De hecho, sin necesidad de pruebas, puedes realizar un diagnóstico de sospecha y llevar a cabo un tratamiento; por ejemplo, un paciente que acude a urgencias por dolor abdominal periumbilical de 24 horas de evolución, que en las últimas horas se ha focalizado en fosa iliaca derecha, que está pálido y sudoroso, con una frecuencia cardíaca de 110 lpm y una tensión arterial de 85/45 mmHg, y presenta un signo de Blumberg positivo en la exploración, tiene un diagnóstico de sospecha de apendicitis aguda complicada y necesita una cirugía de urgencia sin realizar ninguna prueba complementaria.

-----o-----

Señale la respuesta incorrecta sobre el divertículo de Zenker:

1. Se origina por pulsión debido a una incoordinación de la musculatura faríngea que favorece la herniación de la mucosa esofágica
2. Se localiza en la parte anterior de la hipofaringe
3. Puede causar halitosis , regurgitación , disfagia , tos e incluso neumonías por aspiración
4. El tratamiento consiste en la miotomía cricofaríngea por vía endoscópica o quirúrgica

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta sobre el divertículo de Zenker, nos piden señalar la incorrecta y en este caso es la respuesta número 2 la incorrecta puesto que como debemos saber anatómicamente el divertículo se sitúa en la parte posterior de la hipofaringe, por encima del músculo cricofaríngeo y por debajo del músculo constrictor inferior faríngeo

-----O-----

La etiología litiasica corresponde aproximadamente al 90% de los pacientes con colecistitis aguda. Existen factores claramente relacionados con el aumento de litogénesis biliar en algunos pacientes. Señale cuál de los siguientes NO es factor de riesgo para su desarrollo:

1. Pérdida de peso excesiva o acelerada.
2. Ayuno prolongado en pacientes con nutrición parenteral prolongada.
3. Sexo masculino.
4. Enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La frecuencia de la litiasis biliar aumenta con la edad y es 2-3 veces más frecuente en mujeres que en varones (marcamos la opción de respuesta 3). Otro factor de riesgo para el desarrollo de litiasis biliar es la obesidad, situación en la que la secreción biliar de colesterol está aumentada. La rápida pérdida de peso que se produce de forma típica tras cirugía bariátrica también aumenta significativamente la incidencia de litogénesis biliar debido al catabolismo lipídico de la fase de adelgazamiento rápido que sobresatura la bilis con colesterol favoreciendo la precipitación de cristales y con ello la génesis de cálculos, además de la alteración de la circulación enterohepática de ácidos biliares que se produce a nivel de íleon terminal, cuyo trastorno puede deberse a la disminución del tramo intestinal funcional en procedimientos de cirugía bariátrica o tras resección de segmentos de íleon terminal en pacientes con enfermedad de Crohn o directamente por su lesión inflamatoria derivada de la enfermedad. El ayuno intestinal prolongado produce estasis biliar ya que no existe el estímulo del alimento a nivel intestinal y la secreción de enzimas digestivas como la colecistoquinina está disminuida, lo que favorece la precipitación de los componentes biliares. Otros factores implicados menos importantes son las vagotomías, anemias hemolíticas, cirrosis hepática o fármacos como los anticonceptivos orales, fibratos, o la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos.

-----O-----

Los hallazgos radiológicos característicos de la acalasia son los siguientes, excepto:

1. Contracciones terciarias
2. Defecto de peristalsis del esófago proximal
3. Afilamiento de la luz en el EEI
4. Dilatación del cuerpo esofágico

Resp. Correcta: 2

Comentario: La acalasia es un trastorno de la motilidad esofágica distal y no proximal.

-----O-----

Un paciente joven que presenta enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), tendría indicación absoluta de realizar una técnica quirúrgica tipo funduplicatura en

todas las siguientes, EXCEPTO:

1. Fenómenos hemorrágicos de repetición.
2. Infecciones respiratorias de repetición.
3. Falta de respuesta a tratamiento médico correcto.
4. Esófago de Barrett.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Son indicaciones absolutas de cirugía con una técnica antirreflujo aquellos pacientes que, tras ser correctamente informados, rechazan el tratamiento médico por su coste excesivo o por miedo a los efectos colaterales de la medicación y aquellos que presentan falta de respuesta completa, pese al tratamiento médico correcto y controlado. Asimismo, también lo son los pacientes que presentan complicaciones, que pueden ser respiratorias de repetición, fenómenos hemorrágicos de repetición, esofagitis grado 2 o superior y estenosis que no se controlan con dilataciones (pueden precisar esofagectomía). Sin embargo, la presencia de metaplasia intestinal, es decir, el esófago de Barrett, se considera una indicación relativa, es decir, el paciente puede decidir entre la opción quirúrgica o la opción médica, ya que ninguna de las dos opciones puede hacer prescindir de los controles endoscópicos periódicos debido al riesgo de malignización (marcamos la opción de respuesta 4).

-----O-----

¿Cuál es la lesión quística pancreática MÁS frecuente?

1. Neoplasia papilar mucinosa intraductal.
2. Pseudoquiste pancreático.
3. Cistoadenoma seroso.
4. Neoplasia quística mucinosa.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta que recuerda que debemos saber que la lesión quística más frecuente en el páncreas es el pseudoquiste pancreático (respuesta 2 correcta), una condición benigna que constituye la complicación más habitual de la pancreatitis aguda. Su etiología generalmente se debe a la inflamación de la glándula pancreática que genera lesiones en el conducto pancreático, de forma más frecuente ante una pancreatitis crónica. La mayoría se encuentran localizados en el cuerpo y cola del páncreas. Las principales características de los pseudoquistes pancreáticos son las concentraciones altas de amilasa, con niveles de CEA intraquísticos muy bajos, lo que permite discenir del resto de opciones, que corresponden a neoplasias quísticas en las que las lesiones más frecuentes son las neoplasias quísticas mucinosas.

-----O-----

La laparoscopia es el abordaje alternativo a la cirugía abierta en el abdomen. Este abordaje ha revolucionado la cirugía, habiéndose demostrado en bastantes patologías sus evidentes beneficios sobre los abordajes clásicos. El procedimiento consiste en la realización de las mismas técnicas quirúrgicas que se hacen en cirugía abierta mediante la realización de pequeñas incisiones en el abdomen en número variable según la técnica, a través de las que se introducen una cámara y el instrumental quirúrgico específico; la cámara está conectada a una pantalla o monitor que

constituye el campo visual del cirujano. La obtención de un buen campo quirúrgico se logra con la realización de un neumoperitoneo controlado, introduciendo dióxido de carbono en la cavidad abdominal. Todo ello permite una buena visualización. Con respecto a la laparoscopia, es INCORRECTO que:

1. La laparoscopia es de elección en la salpingoclasia.
2. La laparoscopia propicia un mejor retorno venoso por la hipertensión abdominal.
3. Algunas de las ventajas de la laparoscopia son la menor agresividad para el paciente y la recuperación más rápida.
4. La laparoscopia provoca un menor número de adherencias.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La laparoscopia provoca un peor retorno venoso por la hipertensión abdominal (opción 2 incorrecta, por lo que la marcamos). Esta pregunta nos sirve para ver dos cosas: las preguntas largas las empezamos por el final (el enunciado es totalmente innecesario) y que es muy fácil cambiar una palabra de una opción de respuesta (mejor por peor, alto por bajo, etc.).

-----O-----

Sobre el tratamiento del cáncer colorrectal, es cierta una de las siguientes afirmaciones:

1. La resección de metástasis hepáticas del cáncer colorrectal no está indicada por los malos resultados en cuanto a la supervivencia.
2. La radioterapia postoperatoria no disminuye las recidivas locales, aunque proporciona mejor calidad de vida a los pacientes.
3. Los tumores del tercio medio del recto no se pueden tratar con resección anterior baja.
4. Los tumores colorrectales con afectación ganglionar (estadios C de Dukes) requieren tratamiento adyuvante.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Las metástasis hepáticas de cáncer colorrectal deben tratarse de forma agresiva pues se consiguen mejoras relevantes en la supervivencia, respuesta 1 falsa.

La RT postoperatoria en el cancer de recto se ha dejado de utilizar por la alteración funcional que provoca, aunque sí conseguía disminuir la tasa de recidiva local. En la actualidad si se conoce que se trata de un tumor localmente avanzado, lo indicado es la administración de la QT-RT PREOPERATORIA.

Por lo general, los tumores de recto extraperitoneal, medio e inferior se deben tratar mediante RAB con escisión mesorrectal total.

La administración de QT adyuvante está indicada cuando existe afectación ganglionar (N+). Respuesta 4 correcta

-----O-----

Varón de 55 años, fumador y bebedor importante, sin otros antecedentes, que acude a

consulta por disfagia para sólidos progresiva, de pocos meses de evolución, junto con pérdida de 10 kg de peso y astenia. Su sospecha diagnóstica es:

1. Acalasia.
2. Esclerodermia.
3. Carcinoma esofágico.
4. Estenosis péptica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso importante sobre el carcinoma de esófago (respuesta 3 correcta). Sospecha siempre cáncer de esófago en varones con antecedentes personales de alcoholismo y tabaquismo, con disfagia para sólidos de reciente instauración y pérdida de peso. A diferencia de los trastornos motores, la disfagia es inicialmente para sólidos y progresivamente a alimentos semisólidos, líquidos hasta llegar a afagia completa.

-----O-----

Señale cuál de las siguientes NO se considera una indicación de tratamiento quirúrgico en la ERGE:

1. Sintomatología persistente a pesar de tratamiento médico correcto, que impide una adecuada calidad de vida.
2. Hernia hiatal por deslizamiento.
3. Estenosis pépticas que no se controlan con dilataciones.
4. Displasia de alto grado en pacientes con esófago de Barret.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La hernia hiatal por deslizamiento o tipo I ni es indicación quirúrgica en si misma si no tiene indicación quirúrgica la ERGE asociada.

La displasia de alto grado en las biopsias de E. Barret es indicación de esofaguectomía por el elevado porcentaje de carcinoma infiltrante en las piezas resecadas.

-----O-----

De las siguientes patologías esofágicas, indique la que NO tiene indicación quirúrgica:

1. Acalasia en paciente joven.
2. Hernia de hiato por deslizamiento asintomática.
3. Hernia paraesofágica asintomática.
4. Estenosis refractaria a dilataciones.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La hernia paraesofágica, debido al riesgo de complicaciones tipo hemorragia o volvulaciones, debe ser tratada quirúrgicamente, aunque sea asintomática, a diferencia de la hernia por deslizamiento, que solo operaremos en el caso de que produzca síntomas o complicaciones. Realizaremos cirugía de la acalasia en

jóvenes, o por fracaso, o contraindicación de dilataciones. Es importante que recuerdes las indicaciones de cirugía en el RGE, que se resumen en: sintomatología persistente o complicaciones (estenosis, esofagitis grado II, hemorragia o complicaciones respiratorias).

Señale la INCORRECTA en relación al divertículo de Zenker:

1. El método diagnóstico de elección es la endoscopia.
2. Puede dar lugar a aspiración traqueobronquial.
3. Ocasionalmente produce una obstrucción total del esófago.
4. Surge de la parte posterior de la faringe.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El divertículo de Zenker se localiza en la parte posterior de la hipofaringe, por encima del músculo cricofaríngeo y debajo del músculo constrictor inferior faríngeo. Se origina por pulsión, debido a una incoordinación de la musculatura faríngea (que favorece la herniación de la mucosa a través del triángulo de Killian).

Puede causar halitosis, regurgitación, disfagia orofaríngea, tos, neumonía por aspiración e incluso obstrucción completa por compresión.

Como complicaciones, puede producir episodios de broncoaspiración, formación de fistulas entre divertículo y la tráquea, hemorragia intradiverticular y mas raramente, la aparición de un carcinoma epidermíode dentro del divertículo.

El método diagnóstico de elección es el estudio baritado.

El tratamiento se indica en los pacientes sintomáticos o con divertículos grandes, consiste en la ablación, bien por vía endoscópica o quirúrgica, realizando una miotomía cricofaríngea y extirpando el divertículo, si es pequeño, la miotomía es suficiente.

¿Qué opción debemos considerar de elección en el tratamiento de un pseudoquistes inferior de 6 cm de diámetro y asintomático que se ha desarrollado como complicación en una pancreatitis aguda?:

1. Esperar evolución clínica de 4-6 semanas.
2. Somatostatina (perfusión iv) u octreotido sc.
3. Drenaje quirúrgico interno.
4. Drenaje endoscópico guiado por ecoendoscopia.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Caso clínico típico, puesto que la actitud hacia el pseudoquistes pancreático ya había sido preguntada en convocatorias previas. Los pseudoquistes son formaciones de contenido líquido no recubiertas del epitelio de los conductos pancreáticos, que tampoco tienen una cápsula propiamente dicha y que se producen por el acúmulo de secreciones pancreáticas tras agresiones diversas en el seno del tejido pancreático, en su

mayoría por pancreatitis. Su contenido es muy rico en enzimas pancreáticos.

Un 25- 40% se resuelven de forma espontánea. Por ello, los pseudoquistes asintomáticos deben vigilarse periódicamente sin tratamiento (respuesta 1 correcta). El tratamiento quirúrgico de los pseudoquistes de páncreas, cuando está indicado, consiste en una derivación interna, es decir drenar el contenido del pseudoquiste (secreciones pancreáticas) al tubo digestivo (que es donde vierte de forma fisiológica el páncreas su secreción). Esto puede hacerse con diferentes técnicas como la cistoyeyunostomía en Y de Roux, la cistogastrostomía y la cistoduodenostomía. En aquellos casos en los que el pseudoquiste se localice en la cola pancreática una opción adecuada es la pancreatectomía distal que incluye el pseudoquiste. Sólo en los casos en los que se produce la infección del pseudoquiste con importante repercusión clínica estará indicado realizar un drenaje externo.

-----o-----

La causa más frecuente de obstrucción intestinal en una paciente intervenida de histerectomía y apendicitis aguda hace es:

1. Adherencias.
2. Cáncer de colon sigmoideo.
3. Hernia inguinal.
4. Hernia crural.

Resp. Correcta: 1

Comentario: En pacientes con intervenciones previas, la causa más frecuente de obstrucción son las adherencias o bridas. Si la cirugía previa fue de causa oncológica, hay que pensar en la posibilidad de una carcinomatosis peritoneal. Si no existen intervenciones previas, habrá que descartar otras causas de obstrucción (hernias, ileo biliar, bezoar, enteritis ...). En estos pacientes se instaura tratamiento específico de la causa.

-----o-----

Hombre de 52 años de edad derivado al servicio de digestivo por cuadro de hematoquecia, tenesmo y reducción del diámetro de las heces. Se realizan una serie de pruebas, diagnosticándose un adenocarcinoma de sigma sin metástasis a distancia. El paciente es intervenido quirúrgicamente y remitido a la consulta de oncología médica para valorar tratamiento quimioterápico complementario. ¿Cuál de los siguientes factores es de mal pronóstico tras la resección quirúrgica y habrá que tener en cuenta a la hora de planificar el tratamiento de quimioterapia?

1. La presencia de anemia al diagnóstico.
2. La existencia de antecedentes familiares de cáncer colorrectal.
3. El tamaño de la lesión primaria y la diferenciación histológica.
4. La perforación o adhesión del tumor a órganos adyacentes.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Además del estadio, otros factores relacionados con la histología y características específicas del tumor intervenido influyen en el pronóstico de un paciente con cáncer de colon, determinando en ocasiones, la necesidad o no de recibir tratamiento adyuvante. En la tabla 22 del manual (10ª edición) se especifican estos factores pronósticos a los que hace alusión la pregunta. La perforación serosa (T4) que implique adherencia a órganos adyacentes o genere una perforación libre, es claramente uno de esos factores de mal pronóstico que obligan a la administración de quimioterapia postoperatoria. Por lo tanto, la respuesta

4 es la correcta. Las respuestas 1 y 2 no tienen carácter pronóstico, mientras que la 3 es sólo parcialmente correcta, ya que sí es un factor de mal pronóstico la presencia de un tumor pobremente diferenciado (diferenciación histológica) mientras que el tamaño no lo es.

-----O-----

Cual de los siguientes no es considerado un factor de mal pronóstico en el CCR:

1. Invasión de órganos adyacentes
2. Aneuploidía celular
3. Anemia microcítica al diagnóstico
4. Tumor poco diferenciado

Resp. Correcta: 3

Comentario: La anemia microcítica es muy característica en el diagnóstico del CCR pero no implica mal pronóstico del mismo

-----O-----

Paciente politraumatizado que en la TC toracoabdominal presenta un hematoma retroperitoneal importante. ¿Cuál será nuestra primera sospecha como causa del hematoma?

1. Lesión de la arteria ureteral.
2. Rotura parcial de una vena renal.
3. Fractura de la pelvis.
4. Rotura de uretra.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La causa más frecuente de hematoma retroperitoneal es la fractura de pelvis. Cuando es inestable por apertura del anillo pélvico se puede comprimir el sangrado con una faja o hamaca pélvica. Sin embargo, cuando la inestabilidad es en el plano vertical por fractura a dos niveles del anillo pélvico, la fijación debe realizarse mediante fijador externo .

-----O-----

Respecto al abdomen agudo:

1. Todo abdomen agudo requiere tratamiento quirúrgico
2. En el abdomen agudo de causa visceral, el dolor es característicamente profundo, sordo y mal localizado
3. Si la sospecha clínica es de perforación de colon, podría estar indicada la realización de colonoscopia para cerrar el defecto.
4. El signo de Blumberg es patognomónico de apendicitis aguda

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Es evidente que no todo paciente con abdomen agudo requiere cirugía, de hecho hay multitud de causas que son susceptibles de tratamiento médico incluso causas extraabdominales.

El dolor inicial del abdomen agudo afecta al peritoneo visceral y responde a las características que enumera la respuesta 2.

La colonoscopia está contraindicada ante sospecha de perforación.

El signo de Blumberg o signo de rebote se presenta en la Apendicitis aguda pero no es patognomónico porque también está presente en muchos otros cuadros de abdomen agudo de distintas etiologías.

-----O-----

Un paciente de 65 años diagnosticado desde hace 30 años de reflujo gastroesofágico con esofagitis, y de esófago de Barrett desde hace 8 años, seguido con revisiones anuales en la consulta. En la última biopsia realizada se ha observado displasia severa. Señale cuál es la actitud más correcta en este caso:

1. Endoscopia y nueva biopsia dentro de 6 meses.
2. Esofagectomía distal programada.
3. Iniciar tratamiento con antihistamínicos anti-H2, y nueva revisión en 6 meses.
4. Iniciar tratamiento con omeprazol, y nueva revisión en 6 meses.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La presencia en un esófago de Barret de displasia severa debe considerarse como que ya existe un adenocarcinoma o que el riesgo de desarrollarlo es muy elevado y en forma inminente. Por todo ello, en esa situación, lo que se recomienda es la esofaguectomía de la zona afecta. Ultimamente se ha desarrollado procedimientos endoscópicos como la abrasión, pero su eficacia en estudios amplios todavía no ha sido suficientemente contrastada.

-----O-----

¿Cuál es el tratamiento de un paciente diagnosticado de melanoma en conducto anal?:

1. Resección anterior baja.
2. Resección local.
3. Amputación abdominoperitoneal.
4. Radioterapia más quimioterapia.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los tumores anales son raras. Suelen presentarse en varones jóvenes y el más frecuente es el de células escamosas, que se trata con resección local o radioterapia. El melanoma es muy raro y en caso de que aparezca se realiza amputación abdominoperitoneal.

-----O-----

El orificio inguinal superficial es un orificio en:

1. Fascia de Scarpa.
2. Fascia transversalis.
3. Fascia del oblicuo mayor.
4. Fascia del oblicuo menor.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El orificio inguinal superficial constituye el límite anterior del conducto inguinal, y está formado por las fibras del Músculo oblicuo externo del abdomen que a ese nivel se abren generando pilares que lo circunscriben.

Mujer de 43 años que consulta en Urgencias por un cuadro de 48 horas de evolución de dolor abdominal focalizado en hipocondrio derecho y fiebre de 38,3 °C. Solicita una analítica con los siguientes resultados: leucocitos 13.500/mm³, (VN 5.000-10.000), neutrofilia 87%, bilirrubina total: 1,2 mg/dL, bilirrubina directa: 0,3 mg/dL, GGT: 30 mU/mL, fosfatasa alcalina: 40 U/L. Se le realiza una ecografía de abdomen que muestra colecistitis aguda litiásica no complicada. ¿Cuál le parece el tratamiento MÁS correcto para la paciente?

1. Antibioticoterapia intravenosa y colecistectomía programada.
2. Colecistectomía laparoscópica.
3. Colecistostomía percutánea radioguiada.
4. Alta a domicilio con tratamiento antiinflamatorio y analgesia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre la colecistitis aguda. Debes saber que el tratamiento de elección es la cirugía precoz mediante colecistectomía laparoscópica generalmente, sobre todo en pacientes sin factores de riesgo y diagnóstico precoz como en la paciente presentada (respuesta 2 correcta). Sin embargo, ante casos en los que el paciente presente un alto riesgo quirúrgico o el cuadro tenga una evolución mayor a 72 horas se debe plantear hacer un manejo médico conservador con antibioticoterapia y programar la cirugía posteriormente en mejores condiciones, tanto anatómicas de la vesícula como de la situación clínica del paciente. Si ante el manejo conservador en un paciente de alto riesgo no hay mejoría con el tratamiento médico optimizado o presenta signos de sepsis, se debe considerar la realización de una colecistostomía percutánea.

¿Cuál de las siguientes enfermedades necesita con más frecuencia de la actuación del cirujano?

1. Enfermedad de Crohn.
2. Colitis ulcerosa.
3. Gastritis de estrés.
4. Enfermedad de Whipple.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La enfermedad de Whipple es una enfermedad infecciosa que no se trata quirúrgicamente. Del mismo modo, la gastritis de estrés se trata médicamente y solo requiere cirugía raramente, cuando existe un sangrado que no cede con tratamiento médico y endoscopia.

Respecto a la enfermedad Inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa necesita cirugía en torno al 20-25% de los casos, con intención curativa.

Sin embargo, la enfermedad de Crohn requiere cirugía en el 75 % de los pacientes, en muchas ocasiones cirugías repetidas, dado que la enfermedad no es curable.

-----O-----

Paciente de 60 años con sensación de obstrucción en el cuello cuando traga. Señala además que, cuando bebe líquidos, siente como un "gorgojeo" en la garganta y que a veces regurgita porciones de alimentos no digeridas. Su mujer le ha dejado porque no soporta su aliento. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Carcinoma epidermoide del 1/3 superior del esófago.
2. Parálisis cricofaríngea.
3. Rumiación psicógena.
4. Divertículo de Zenker.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El divertículo de Zenker se localiza en la parte posterior de la hipofaringe, por encima del músculo cricofaríngeo y debajo del músculo constrictor inferior de la faringe (triángulo de Killian). Se originan por pulsión, debido a una mala coordinación de la musculatura faríngea. Puede causar halitosis, regurgitación, disfagia orofaríngea e incluso una obstrucción completa por compresión.

Como complicaciones, puede producir episodios de broncoaspiración, formación de fistulas entre el divertículo y la tráquea, hemorragia intradiverticular (sobre todo con la aspirina) y, más raramente, la aparición de un carcinoma epidermoide dentro del divertículo. La colocación de una sonda nasogástrica o la realización de una endoscopia en estos pacientes tiene riesgo de perforación del divertículo, por lo que deben evitarse. El tratamiento es quirúrgico, realizando una miotomía cricofaríngea y extirpando el divertículo. Si es pequeño, la miotomía es suficiente.

-----O-----

Un paciente acude a su consulta refiriendo cambio del ritmo intestinal con tendencia al estreñimiento, rectorragia, cansancio y una anemia en la analítica. Ante la sospecha de cáncer colorrectal, no es adecuado afirmar que:

1. Debe practicarse un tacto rectal y colonoscopia con toma de biopsia.
2. El estudio de extensión del cáncer de colon se realiza con TC toraco-abdominal añadiéndose RM de recto +/- ecoendoscopia rectal en el cáncer de recto
3. El CEA se utiliza fundamentalmente durante el seguimiento de los pacientes con cáncer colorrectal.
4. Todos los pacientes tiene el CEA elevado al diagnóstico.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El CEA en cáncer colorrectal se realiza para controlar analíticamente en el seguimiento en busca de elevaciones del mismo que puedan orientar o alertarnos ante una posible recidiva tumoral.

Todos los tumores no tienen el CEA elevado al diagnóstico por lo que en ellos será menos útil esta estrategia.

-----O-----

Entre las causas de carcinoma epidermoide de esófago, se consideran las siguientes EXCEPTO:

1. Tabaco.
2. Alcohol.
3. Acalasia crónica.
4. Reflujo gastro-esofágico.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Entre los diferentes tipos de cáncer de esófago, debemos distinguir dos variedades principales: el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma esofágico. En realidad, lo que están haciendo en esta pregunta es tratar que los confundamos entre sí.

El carcinoma epidemoide esofágico se ha relacionado con hábitos como el tabaco y el alcohol, tal como se expresa en las dos primeras respuestas, siendo además una asociación fuerte. La acalasia también está vinculada a este tipo de cáncer, aunque no justifica un número de casos tan elevado como el tabaquismo. Por último, el síndrome de Plummer- Vinson, que se asocia a la anemia ferropénica, también se considera factor de riesgo.

La respuesta correcta es la 5. El reflujo gastroesofágico produce una metaplasia columnar en la región inferior del esófago, conocida como esófago de Barrett. En ocasiones, esta metaplasia se complica con displasia de diferentes grados, lo que finalmente deriva en un adenocarcinoma esofágico.

Recuerda que, topográficamente, el esófago de Barrett aparece en el tercio inferior, mientras que el carcinoma epidermoide es más propio del tercio medio.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes factores de riesgo no se asocia al carcinoma epidermoide de esófago?

1. Alcohol
2. Tabaco
3. Esófago de Barret
4. Acalasia

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se trata de una pregunta sobre factores de riesgo de carcinoma epidermoide, en este caso es el esófago de Barret el que debemos asociarlo con el adenocarcinoma esofágico que ha experimentado un incremento en las últimas décadas, en pacientes jóvenes y de raza blanca

-----O-----

Varón de 82 años que consulta por presentar en los dos últimos años numerosos

episodios de disfagia al inicio de la deglución, halitosis y, en ocasiones, regurgitación maloliente. Además, describe en varias ocasiones, y sin guardar relación con la deglución, accesos de tos y disnea. Entre los siguientes, ¿cuál sería el diagnóstico más probable?:

1. Divertículo por tracción.
2. Fibrosis esofágica postmediastinitis.
3. Divertículo de Zenker.
4. Esófago de Barrett.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El divertículo de Zenker se desarrolla en la región posterior de la hipofaringe en la unión con el esófago superior. Se acompaña de disfagia tipo faríngeo por disfunción de la musculatura cricofaríngea. Además, el acúmulo de alimento condiciona halitosis, e incluso en ocasiones regurgitación maloliente. La acalasia, las estenosis del esófago de Barrett y la fibrosis esofágica dan disfagia de esófago inferior, no tipo faríngeo.

-----o-----

En el esófago de Barrett, la realización de una técnica antirreflujo con demostración manométrica y pHmétrica, de ser eficaz:

1. Hace retroceder siempre las alteraciones de la mucosa esofágica.
2. No hace retroceder la enfermedad, pero impide la evolución a carcinoma.
3. No hace desaparecer el potencial de que se desarrolle un adenocarcinoma.
4. Tras dos estudios consecutivos de pHmetría esofágica normal separados entre sí por al menos 12 meses, puede prescindirse de nuevas valoraciones del paciente.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El esófago de Barrett consiste en la presencia de un epitelio columnar de tipo intestinal, que aparece en algunos pacientes con esofagitis por reflujo gastroesofágico. Este cambio, el tipo de epitelio obedece a fenómenos de metaplasia, e implica un riesgo de malignización, por lo que habrá que vigilarlo endoscópicamente de forma periódica, ya que existe potencial de malignización (respuesta 3 correcta). Lo que hace la técnica antirreflujo es reducir el riesgo de progresión a displasia y, si la hubiera, descende el riesgo de malignización, aunque no se elimina.

-----o-----

¿Cuál de los siguientes factores de riesgo NO se asocia con el carcinoma epidermoide de esófago?

1. Acalasia
2. Esófago de Barret
3. Alcohol
4. Síndrome de Plummer- Vinson

Resp. Correcta: 2

Comentario: El esófago de Barret es un factor de riesgo asociado al adenocarcinoma de esófago , no al

carcinoma epidermoide.

-----O-----

Mujer de 40 años con anemia ferropénica y disfagia de larga evolución a la que se realiza una esofagoscopia encontrando una membrana fibrosa que obstruye parte de la luz del esófago de un modo excéntrico un poco más abajo del músculo cricofaríngeo. En este caso debemos pensar que se trata de:

1. Esófago de Barrett.
2. Síndrome de Mallory-Weiss.
3. Carcinoma de esófago.
4. Síndrome de Plummer-Vinson.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La presencia de membrana fibrosa que obstruye la luz del esófago por debajo del músculo cricofaríngeo es típica del síndrome de Plummer- Vinson, que con frecuencia se asocia a una situación de ferropenia crónica. El tipo de disfagia que da es faríngea.

-----O-----

Indique cuál NO es una indicación para cirugía urgente de colitis ulcerosa:

1. Megacolon tóxico que persiste tras 24 horas de tratamiento médico.
2. Colangitis esclerosante refractaria a tratamiento.
3. Perforación colónica.
4. Hemorragia masiva.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La colitis ulcerosa (CU) es una enfermedad idiopática inflamatoria que afecta a la mucosa del recto y se extiende de forma proximal para afectar una longitud variable del colon. La base del tratamiento es médica. Sin embargo, se estima que el 30-40% de los pacientes requerirán cirugía. De ellos aproximadamente el 20% requerirán una cirugía urgente ante un compromiso vital importante. Las principales indicaciones de cirugía urgente la constituyen el fracaso en el tratamiento médico en pacientes con colitis tóxica o fulminante y el megacolon tóxico siendo menos frecuente la perforación y la hemorragia masiva. La presencia de efectos sintomatología extraintestinal refractaria a tratamiento médico podría hacer indicar una cirugía electiva en CU, pero nunca sería indicación una colangitis esclerosante refractaria (RC b) ya que su sintomatología es independiente de la afectación colónica.

-----O-----

La cirugía laparoscópica es un abordaje alternativo que ha revolucionado la cirugía habiéndose demostrado sus ventajas en numerosas patologías ¿Cuál de las siguientes no se considera una de ellas?

1. Genera menos adherencias intraabdominales
2. Menor agresión quirúrgica
3. Menor riesgo de trombosis venosa profunda
4. Menor íleo paralítico

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre cirugía laparoscópica en este caso la respuesta correcta es la número 3, puesto que una de las desventajas de la cirugía laparoscópica es que conlleva un MAYOR riesgo de trombosis venosa profunda

-----O-----

Un paciente refiere que tiene sangrado de caracter distal diariamente sin prolapso. Usted realiza una anuscopia y observa hemorroides internas congestivas con estigmas de sangrado reciente. De qué grado son?

1. Grado 4. Sangrado diario
2. Grado 3. Prolapso asintomático
3. Grado 2. Congestivas en la anuscopia
4. Grado 1. Sin prolapso

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Recuerda la clasificación de las hemorroides internas:

Grado 1: no prolapsadas

Grado2: Prolapso con el esfuerzo, se reduce espontáneamente.

Grado 3: Prolapso con el esfuerzo, se reduce manualmente.

Grado 4: prolapso irreductible, permanente

-----O-----

Un hombre de 74 años refiere pirosis diaria desde la juventud que trata con alcalinos. Se le practica una endoscopia digestiva alta que muestra esofagitis erosiva leve y la unión escamosa columnar desplazada aproximadamente 7 cm respecto a la porción más proximal de los pliegues gástricos. Las biopsias del esófago distal revelan que el epitelio escamoso normal ha sido reemplazado por epitelio columnar de tipo intestinal con displasia de bajo grado. ¿Cuál es la opción MÁS apropiada para el manejo de este paciente?

1. Dado que la esofagitis es leve y la displasia de bajo grado, se aconseja continuar tratamiento con alcalinos.
2. Tratamiento indefinido con dosis altas de inhibidores de la bomba de protones, ya que se ha demostrado que así se evita la progresión del esófago de Barrett a adenocarcinoma, haciendo innecesaria la vigilancia endoscópica.
3. Endoscopias de vigilancia periódicas y tratamiento con inhibidores de la bomba de protones durante menos de 12 semanas, ya que tratamientos más prolongados se asocian a un alto riesgo de desarrollo de gastrinomas.
4. Endoscopias de vigilancia periódicas (cada 6-12 meses) y tratamiento indefinido con inhibidores de la bomba de protones.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En la pregunta nos describen a un paciente que tiene esófago de Barrett, con displasia de bajo grado. El manejo de este paciente consiste en realizar tratamiento indefinido con un inhibidor de la bomba de protones (o funduplicatura de Nissen) y una biopsia de control cada 6-12 meses, tal como se indica en la opción de respuesta 4. En el esófago de Barrett con displasia de alto grado (o severa), confirmada por dos patólogos, el manejo clásico consiste en realizar una esofagectomía profiláctica, aunque se está popularizando la erradicación endoscópica (mucosectomía, radiofrecuencia, etc.) en casos seleccionados.

-----O-----

¿En cuál de los siguientes casos la laparoscopia puede ofrecer MÁS ventajas que la laparotomía convencional en el manejo de un abdomen agudo?

1. Niños con clínica típica de apendicitis aguda no perforada.
2. Mujeres en edad fértil con dudas entre apendicitis y anexitis.
3. Jóvenes con peritonitis de origen no claro.
4. Ancianos con sepsis severa por colecistitis aguda.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las principales ventajas de la laparoscopia en relación con la cirugía convencional son una menor agresividad para el paciente, una recuperación más rápida y una menor tasa de complicaciones. Por ello, se ha convertido en la técnica de elección para determinadas intervenciones: colecistectomías, funduplicaturas, salpingoclasia, tratamiento quirúrgico de la acalasia y cuando no existe un diagnóstico claro. En este caso clínico, la única opción de respuesta donde existen dudas diagnósticas es la 2, por lo que sería la correcta. En este caso, la paciente se beneficiaría mucho si se utiliza la laparoscopia, ya que en caso de padecer una anexitis, se hubiera ahorrado una laparotomía, ya que el tratamiento sería esencialmente médico. Pueden surgir dudas con la opción 4, ya que las colecistectomías pueden realizarse por laparoscopia, pero nos dicen que es un anciano con sepsis severa y, al ser una situación muy urgente, debemos optar por la técnica más rápida, que sería la cirugía convencional.

-----O-----

¿Cuál no constituye una indicación de primera elección de cirugía laparoscópica?

1. Colecistectomía.
2. Nissen.
3. Pancreatectomía distal.
4. Diagnóstico de dolor abdominal en mujer joven y obesa.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La cirugía laparoscópica ha demostrado ventajas evidentes en múltiples intervenciones.

La colecistectomía y la cirugía del reflujo son dos de las técnicas iniciadas más precozmente y en las que más evidencias existen de sus ventajas, así como en el manejo del abdomen agudo en la mujer fértil (para el diagnóstico diferencial con la patología anexial) y el paciente obeso (en que requeriría una laparotomía mas grande y con mayor riesgo de complicaciones de la herida.

A pesar de que la pancreatectomía distal es una intervención que se puede realizar por vía laparoscópica, sus ventajas aún están por demostrar y no está consolidado como el abordaje de elección

-----O-----

Son indicaciones de tratamiento de un pseudoquiste pancreático de larga evolución, complicación de una pancreatitis aguda litiasica grave, todas las que a continuación se enumeran, EXCEPTO:

1. Presencia de sintomatología importante.
2. Crecimiento en los controles.
3. Antecedentes familiares de cáncer de páncreas.
4. Migración del pseudoquiste a cavidad mediastínica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La indicación para tratar un pseudoquiste se establece por el tiempo de evolución y la sintomatología acompañante. Debemos esperar al menos seis semanas para establecer que es un verdadero pseudoquiste, y que no regresa espontáneamente. Las complicaciones y la sintomatología marcan la indicación de tratamiento. Síntomas como dolor, obstrucción, ictericia, etc. y complicaciones como la infección, o la migración a cavidades, son los más característicos. Por último, debemos tener en cuenta que determinadas localizaciones como la periesplénica, deben de tratarse por el riesgo de sangrado que pueden producir durante su crecimiento. Los antecedentes familiares de cáncer de páncreas no es indicación para operar un pseudoquiste, ya que la relación entre el pseudoquiste y el cáncer de páncreas no está demostrada (marcamos la opción de respuesta 3).

-----O-----

¿Cuál será la actuación prioritaria en el tratamiento de un paciente que es traído al hospital inconsciente, con diversas heridas sangrantes en miembros inferiores y en el tórax, con rotación interna y acortamiento del miembro inferior derecho?

1. Reducir la luxación de la cadera derecha, por el peligro de necrosis de la cabeza femoral.
2. Establecer una vía aérea efectiva.
3. Control de los puntos sangrantes activos.
4. Colocación de un drenaje torácico en cada hemitórax, en previsión de un neumotórax bilateral.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En cualquier paciente politraumatizado, siempre aplicaremos inicialmente el ABCDE, comenzando por la A lo primero es establecer una vía aérea efectiva.

-----O-----

El tratamiento más adecuado para una herida penetrante en tórax consiste en:

1. Cerrar el defecto con puntos de sutura y colocar tubo de tórax alejado de la lesión.
2. Cerrar el defecto con un apósito, fijo en tres puntos y colocar tubo de tórax alejado de la lesión.

3. Dejar abierto el defecto y colocar tubo de tórax alejado de la lesión.
4. Toracotomía urgente.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El tratamiento de un neumotórax abierto secundario a una herida por arma blanca en la región torácica, consiste inicialmente en un vendaje oclusivo estéril de la herida, asegurando 3 lados con tela adhesiva para que funcione como una válvula de escape unidireccional, con posterior colocación de tubo endotorácico alejado del sitio de la herida.

-----O-----

Un paciente alcohólico ha presentado un cuadro de vómitos intensos, acompañado posteriormente de dolor retroesternal y fiebre. En la radiografía de tórax presenta un derrame pleural izquierdo moderado. Se realiza una toracocentesis y se obtiene un líquido seroso con pH de 5,5. Señale cuál de los siguientes es su diagnóstico de sospecha:

1. Derrame pleural maligno.
2. Empiema.
3. Pleuritis reumatoide.
4. Rotura esofágica.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Se trata de una rotura esofágica espontánea postemética o síndrome de Boerhaave, casi siempre en pacientes alcohólicos. Suele cursar con mediastinitis expresada por intenso dolor de localización retroesternal, que aumenta al tragar o respirar, disfagia, crepitación, fiebre y además, derrame pleural izquierdo rico en amilasa.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la patología anorrectal en el VIH es cierta?:

1. Hay un riesgo aumentado de cáncer anal.
2. La ulceración anal es frecuentemente secundaria a una infección y responde precozmente a los antibióticos tópicos.
3. La amputación abdominoperineal es el tratamiento de elección para el carcinoma escamoso del ano en los pacientes HIV.
4. Los abscesos perirrectales deben ser tratados inicialmente con antibióticos en los pacientes HIV.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Los pacientes VIH + pueden presentar la patología anorrectal común a la población en general como son fístula anal (15%), absceso (30%), hemorroides (17%); sin embargo presentan otras manifestaciones características, debido a la práctica de relaciones sexuales anales que los predispone a enfermedades de transmisión por esa vía: el 95% de los homosexuales presentan anticuerpos contra el virus del herpes tipo 2, del 90 al 100% son seropositivos para el citomegalovirus (CMV), la ileocolitis sintomática por CMV es la infección intestinal más común en pacientes con SIDA, ocurriendo en aproximadamente el 10%; el 55% de los homosexuales son portadores del gonococo, la mayoría en forma asintomática en tanto que, los condilomas acuminados se han reportado en un 40 a 60% de los homosexuales y pueden mantenerse

asintomáticos, la CDC informó un incremento en la incidencia de los condilomas acuminados de 500% de 1966 a 1981. Se ha comprobado como hay una incidencia de carcinoma anorrectal en los VIH positivos con condilomas.

Un paciente presenta una perforación del esófago torácico secundaria a la realización de una endoscopia digestiva alta hace 12 horas. De los siguientes síntomas, ¿cuál es el que espera encontrar con MÁS frecuencia?

1. Dolor torácico.
2. Fiebre.
3. Disnea.
4. Crepitación cervical.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Los síntomas que aparecen tras una perforación esofágica son, por orden de frecuencia, el dolor (71% - respuesta 1 correcta -), la fiebre (51%), la disnea (24%) y la crepitación (22%). No es necesario que aparezcan todos a la vez para llegar a un diagnóstico de sospecha, y menos si nos dan un dato clave como es un antecedente de intervencionismo endoscópico reciente, que es la causa más frecuente de perforación esofágica.

Entre las sinuientes aseveraciones referentes al divertículo de Zenker hay una FALSA. Señálela:

1. Se sitúa en la parte posterior e izquierda del límite faringoesofágico.
2. Es más frecuente en varones.
3. Se suele asociar a hernia de hiato.
4. El tratamiento quirúrgico sólo debe realizarse en presencia de complicaciones o de clínica importante.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El divertículo de Zenker se desarrolla en la región posterior de la hipofaringe en la unión con el esófago superior. Se acompaña de disfagia tipo faríngeo por disfunción de la musculatura cricofaríngea. Además, el acúmulo de alimento condiciona halitosis, e incluso en ocasiones regurgitación maloliente. Sucede más en varones y se suele asociar a hernia de hiato. Si es sintomático es ya indicación de miotomía del cricofaríngeo y, si fuera necesario, mejor aún, acompañado de diverticulotomía.

¿Cuál es el tratamiento más eficaz de la acalasia?:

1. Antiespasmódicos.
2. Dilatación del cardias.
3. Esofagomiotomía.
4. Resección de la unión gastroesofágica.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Respecto al tratamiento de la acalasia, tenemos hoy en día varias opciones. La dilatación con balón se considera actualmente la primera opción, siendo efectivo en un 85% de los pacientes. Aunque el resultado a largo plazo es inferior al de la cirugía, tiene la ventaja de ser más barata, así como la posibilidad de indicación de cirugía si ésta fracasa, teniendo similares tasas de complicaciones y de mortalidad. Sin embargo, en los últimos años la cirugía con realización de miotomía modificada de Heller más técnica antireflujo, está ganando gran aceptación sobre todo por el uso de técnicas vía laparoscópica, con menor nº de complicaciones, que las implicadas en la cirugía (respuesta nº 3 correcta). La inyección de toxina botulínica es una técnica novedosa, que mejora la sintomatología sobre todo en ancianos y pacientes con acalasia vigorosa, pero aún no están bien establecidas las indicaciones. Respecto al tto médico, (respuesta 1), son poco útiles, estando únicamente indicados de forma temporal y en edades extremas de la vida. EN CUALQUIER CASO NOS PREGUNTAN POR EL TRATAMIENTO MAS EFICAZ Y ESTE ES LA MIOTOMIA CON TÉCNICA ANTIREFLUJO

-----O-----

Con respecto a los divertículos esofágicos, señale cuál de las siguientes respuestas es FALSA:

1. El cuello de un divertículo de Zenker está situado por encima del músculo cricofaríngeo.
2. El mejor tratamiento para un divertículo faringoesofágico es la diverticulectomía asociada a una miotomía del músculo cricofaríngeo.
3. La pared de los divertículos por pulsión está constituida por mucosa, submucosa y muscular.
4. Los divertículos esofágicos más frecuentes son los de Zenker.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los divertículos esofágicos más frecuentes son los de Zenker, que están situados por encima del músculo cricofaríngeo y se producen como una protrusión en la zona posterior lateral izda. del esófago. La miotomía del músculo cricofaríngeo mejora la disfagia de estos enfermos, pero el tratamiento de elección es la combinación con la diverticulectomía. Los divertículos por pulsión son pseudodivertículos, es decir, están formados por mucosa y submucosa y no por músculo.

-----O-----

Paciente de 52 años, en seguimiento periódico por enfermedad de Barrett, que es diagnosticado de un adenocarcinoma de esófago a nivel de la unión gastroesofágica. La estadificación realizada con TAC y ecoendoscopia muestra un tumor en estadio I (T1 N0). No presenta morbilidad respiratoria, ni criterios que contraindiquen la cirugía. ¿Qué estrategia terapéutica emplearía?

1. Quimiorradioterapia preoperatoria + cirugía.
2. Quimiorradioterapia como único tratamiento.
3. Cirugía por vía transhiatal.
4. Endoprótesis.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El afortunado paciente que presentamos en el caso es de los pocos casos con indicación quirúrgica de entrada en el cáncer de esófago. Presenta un tumor localizado, por lo que podríamos operarlo. Reservamos la neoadyuvancia (con quimio o quimiorradioterapia) para los pacientes diagnosticados en estadios avanzados (por desgracia, la mayoría). Al tratarse de un tumor de esófago distal, la técnica transhiatal es una

buena opción (respuesta 3 correcta). Recuerda que se realiza por medio de laparotomía y cervicotomía y que la anastomosis se hace en el cuello. La reconstrucción del tránsito, en este caso, la haríamos con estómago tubulizado o, si el tumor es muy bajo y finalmente necesitara reseca el estómago, usaríamos el colon.

-----O-----

Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a las hernias de hiato:

1. Consiste en la herniación de un órgano abdominal a través del hiato esofágico
2. Las tipo I o también llamadas por deslizamiento son las más frecuentes
3. Las tipo III o mixtas son las mas frecuentes dentro de las paraesofágicas
4. Siempre tienen indicación quirúrgica

Resp. Correcta: 4

Comentario: No siempre tienen indicación quirúrgica, en las asintomáticas se debe individualizar según las características del paciente y las tipo I seguirán los mismos criterios que la ERGE.

-----O-----

Paciente que tras vomitar de forma intensa y repetida los vómitos se hacen sanguinolentos dando paso a una importante hematemesis. ¿Cómo se llama este cuadro?:

1. Síndrome de Plummer-Vinson.
2. S. de Paterson-Kelly.
3. S. de Mallory-Weiss.
4. S. de Potter.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El síndrome de Mallory- Weiss consiste en el desgarro y erosión de la mucosa esofágica situada anatómicamente dentro de la cavidad gástrica e inducida por los vómitos repetidos. Generalmente cursa con una hemorragia digestiva benigna y autolimitada y, por ello, raramente se precisa cirugía.

-----O-----

Una paciente de 58 años estudiada por dispepsia es remitida desde su médico de atención primaria aportando una ecografía en la que se describe la presencia de cálculos en la vesícula biliar con vía biliar no dilatada sin otros hallazgos relevantes. En la anamnesis la paciente describe molestias vagas postprandiales y algo de pirosis. ¿Su recomendación sería?

1. Recomendar intervención quirúrgica dada la edad de la paciente para evitar complicaciones futuras
2. Recomendar intervención quirúrgica puesto que la sintomatología se justifica por la presencia de coledolitiasis
3. No está indicado el tratamiento quirúrgico en esta paciente
4. Se recomienda la realización de CPRE profiláctica para evitar complicaciones por coledocolitiasis

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La presencia de colelitiasis es muy frecuente en la población y suele ser un hallazgo en el contexto de estudios por dispepsia. El simple hecho de presentar colelitiasis no justifica la intervención quirúrgica para evitar complicaciones futuras, ya que la colecistectomía en sí misma implica una morbilidad. Dentro de las indicaciones de la colecistectomía se encuentran los cólicos de repetición cuya sintomatología no es la que describe la paciente del caso clínico.

La colecistectomía laparoscópica tiene como VENTAJA sobre la colecistectomía por laparotomía:

1. La reducción de la estancia hospitalaria.
2. No se asocia a lesiones de la vía biliar.
3. Es una técnica exenta de mortalidad.
4. Es siempre posible realizarla mediante el abordaje laparoscópico.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El abordaje laparoscópico tiene una serie de ventajas frente al abordaje abierto clásico (laparotomía):

- Menos dolor postoperatorio.
- Menos íleo paralítico postoperatorio.
- Menor tasa de complicaciones de la herida (seroma, infección, eventración).
- Menor índice de adherencias intraabdominales postoperatorias.
- Recuperación posoperatoria más rápida, con menor estancia hospitalaria (respuesta 1 correcta).
- Menor defecto estético.

En una colecistectomía laparoscópica, como en toda intervención quirúrgica, pueden desarrollarse complicaciones intra y postoperatorias. En el caso concreto de la colecistectomía, tanto abierta como laparoscópica, existe el riesgo potencial de lesión de la vía biliar. En ocasiones, por dificultades técnicas, es necesario convertir un abordaje inicialmente laparoscópico a una cirugía "abierta".

A un paciente se le ha realizado una polipectomía endoscópica de un pólipo pediculado de sigma < 2 cm. El resultado anatomopatológico ha sido de carcinoma infiltrante en la submucosa limitado a la cabeza del pólipo. Indique la conducta CORRECTA a seguir:

1. Resección segmentaria del colon afecto.
2. Vigilancia periódica radiológica.
3. Vigilancia periódica endoscópica.
4. Hemicolectomía más linfadenectomía.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Si se tratara de un ca in situ (no infiltrante) o un ca infiltrante limitado a la cabeza del pólipo, no estaría indicado realizar una colectomía y bastaría extirpar el pólipo. Sin embargo, está claro que es necesario un seguimiento de este paciente, porque en él sería más probable encontrar en algún momento otro cáncer de colon, por lo que se realizaría un seguimiento endoscópico (no radiológico, por ser menos sensible en el diagnóstico de esta enfermedad).

La intervención quirúrgica urgente en la pancreatitis ha de contemplarse en una de las situaciones siguientes:

1. La calcemia cae a menos de 7 mg/100 ml.
2. Aparece insuficiencia respiratoria que obliga a la intubación o traqueostomía.
3. Se detecta coledocolitiasis con la colangiografía intravenosa.
4. La TAC abdominal muestra una masa quística grande en la región del páncreas con burbujas aéreas en su interior.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La intervención quirúrgica urgente en el contexto de una pancreatitis aguda es un tema controvertido y sujeto a revisión. Actualmente la indicación más ampliamente aceptada es la existencia de una complicación infecciosa de la pancreatitis bien en forma de un absceso o demostrando la existencia de bacterias en el contexto de un flemón o pancreatitis necrótica. Así pues, la existencia de una colección líquida con burbujas de aire en su interior lo cual sugiere la formación de un absceso sería una indicación de cirugía urgente para el drenaje del mismo si la situación clínica del paciente lo permite. La demostración de coledocolitiasis tiene indicación de una CPRE con esfinterotomía endoscópica de forma precoz (en las primeras 72 horas del cuadro clínico). Otras situaciones como el deterioro clínico del paciente están sujetas a revisión y son las más controvertidas en la actualidad pues presentan complicaciones graves sin haber demostrado firmemente un aumento de la supervivencia del enfermo.

-----o-----

A un paciente de 24 años y con antecedentes familiares de cáncer de colon se le detectan en una colonoscopia cientos de pólipos adenomatosos. Señale de las que se describen a continuación, la actitud terapéutica más adecuada ante la patología que probablemente presenta este enfermo:

1. Extirpar todos los pólipos con asa de polipectomía.
2. Quimioterapia.
3. Proctocolectomía restauradora profiláctica.
4. Revisiones periódicas y cuando se detecte un adenocarcinoma, colectomía total.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El caso clínico nos hace pensar en una poliposis adenomatosa familiar que es indicación de Proctocolectomía.

En casos de recto no afecto, especialmente en pacientes jóvenes podría plantearse la Colectomía total

-----o-----

Una mujer de 75 años sin antecedentes de interés acude a la consulta por presentar dolor epigástrico y disfagia de 4 meses de evolución. Pérdida de 16 kg de peso en los últimos 2 meses. Se solicita una endoscopia digestiva alta que muestra una masa vegetante en el tercio superior del esófago torácico, se toman biopsias que resultan de carcinoma escamoso. Se solicita un TAC en el que se objetiva dicha lesión que infiltra la tráquea sin objetivarse metástasis a distancia ¿Cuál es el tratamiento correcto?

1. Resección endoscópica
2. Esofagectomía + Quimioradioterapia adyuvante
3. Quimioradioterapia neoadyuvante + Reevaluación PET-TC
4. Colocación de una prótesis esofágica recubierta con intención paliativa y asegurar un soporte nutricional adecuado

Resp. Correcta: 4

Comentario: La invasión traqueal es un criterio de irresecabilidad y por tanto para una paciente de 75 años con corta esperanza de vida lo mas adecuado es el tratamiento paliativo.

Respecto a las complicaciones quirúrgicas del trasplante hepático, señale entre las siguientes respuestas cual NO es correcta:

1. En los tres primeros meses se suelen deber a complicaciones técnicas o infecciones postoperatorias.
2. El rechazo del trasplante representa hasta el 80-90% de las pérdidas de injerto.
3. A partir de los tres meses, se relacionan más con infecciones secundarias a la inmunosupresión, rechazo o recidiva de la enfermedad primitiva.
4. Los problemas vasculares y biliares representan las principales complicaciones del trasplante hepático.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las complicaciones precoces después del trasplante de hígado más comunes son las fugas biliares y las estenosis, pero normalmente su manejo puede ser endoscópico.

Sin embargo, la infección es la principal causa de mortalidad, por lo la presencia de fiebre u otros signos de infección requieren una evaluación urgente. Un desafío importante para muchos pacientes después de un trasplante de hígado es la recurrencia de la enfermedad primaria. Los trastornos más comúnmente asociados con la recurrencia incluyen el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la hepatitis C (VHC).

Afortunadamente, la recurrencia del VHB después del trasplante hepático se puede prevenir administrando inmunoglobulina de hepatitis B y antivirales como tenofovir o entecavir. Las complicaciones vasculares suelen producirse en el postoperatorio temprano y pueden afectar a la arteria hepática, vena porta, vena cava y venas suprahepáticas. La trombosis/estenosis de la arteria hepática se suele manifestar como un deterioro brusco y progresivo de la función hepática que, a diferencia de la disfunción primaria del injerto, ocurre tras un periodo variable de función hepática normal. El tratamiento de elección continúa siendo el trasplante urgente, pero cada vez más surge la alternativa de la radiología intervencionista.

Por lo tanto, la respuesta falsa y a marcar, es la B: existe hasta un 5-10% de pacientes que presentan rechazo celular tardío, generalmente durante la reducción programada de la inmunosupresión.

Señale la respuesta incorrecta respecto a los marcadores tumorales del cáncer colorrectal:

1. El Antígeno Carcinoembrionario (CEA) es el marcador tumoral de referencia actualmente
2. Sus valores se normalizan tras 1-4 meses de la intervención
3. Desempeña un papel importante en el cribado del CCR
4. Durante el seguimiento puede detectar precozmente recidiva de la enfermedad incluso antes de que

aparezcan los síntomas

Resp. Correcta: 3

Comentario: Se desaconseja su uso para cribado y únicamente juega un discreto papel de apoyo en el diagnóstico de casos en los que ya se ha establecido el diagnóstico por otros métodos.

-----o-----

Un paciente varón de 65 años acude a su consulta refiriendo notarse un tumoración o bulto en la región lateral izquierda del cuello durante las comidas que aumenta progresivamente de tamaño. Ocasionalmente presenta regurgitación de material maloliente. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y qué pruebas indicaría?

1. Linfoma. ECO cervical.
2. Quiste braquial ECO cervical.
3. Divertículo de Zenker. Esófagograma y manometría esofágica.
4. Absceso periamigdalino. TAC cervical.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El divertículo de Zenker se localiza en la parte posterior de la hipofaringe, por encima del músculo cricofaríngeo y debajo del músculo constrictor inferior de la faringe. Se originan por pulsión, debido a una mala coordinación de la musculatura faríngea. Puede causar halitosis, regurgitación, disfagia orofaríngea e incluso una obstrucción completa por compresión.

Como *complicaciones*, puede producir episodios de broncoaspiración, formación de fistulas entre el divertículo y la tráquea, hemorragia intradiverticular (sobre todo con la aspirina) y, más raramente, la aparición de un carcinoma epidermoide dentro del divertículo. La colocación de una sonda nasogástrica o la realización de una endoscopia en estos pacientes tiene riesgo de perforación del divertículo, por lo que deben evitarse. El *tratamiento* es quirúrgico, realizando una **miotomía cricofaríngea** y extirpando el divertículo. Si es pequeño, la miotomía es suficiente.

-----o-----

¿Cuál de las siguientes estructuras anatómicas constituye el límite lateral del triángulo de Hesselbach permitiendo diferenciar hernias directas e indirectas?

1. Fascia de Scarpa.
2. Fascia transversalis.
3. Ligamento inguinal.
4. Vasos epigástricos inferiores.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El triángulo de Hesselbach, es un espacio anatómico, delimitado lateralmente por los vasos epigástricos inferiores (ramos de las arterias ilíacas), medialmente por la vaina del recto abdominal y caudalmente por el ligamento inguinal (inserción del Músculo oblicuo externo del abdomen). Permiten la diferenciación de hernias inguinoabdominales directas u oblicuas internas o indirectas u oblicuas externas en función de que protruyan de forma medial (directas) o lateral (indirectas) a dichos vasos.

-----o-----

Con respecto a la clasificación de Siewert de los tumores del cardias, es FALSO que:

1. Los tumores de tipo I se localizan 1-5 cm por debajo de la unión gastroesofágica.
2. Los tumores de tipo I suelen ser adenocarcinomas del esófago distal, generalmente relacionado con el esófago de Barrett.
3. Los tumores de tipo III se localizan más allá de 2 cm por debajo de la unión gastroesofágica.
4. Los tumores de tipo II se localizan entre 1 cm por arriba y 2 cm por debajo de la unión gastroesofágica.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Los tumores tipo I de la clasificación de Siewert son los que se localizan 1-5 cm por encima de la UGE (opción 1 falsa, por lo que la marcamos). Se trata de un adenocarcinoma del esófago distal generalmente relacionado con el esófago de Barrett.

-----o-----

Hombre de 65 años que consulta por disfagia a sólidos desde hace dos meses. La esofagoscopia evidencia tumoración a 30 cm de arcada dental, parcialmente estenosante, con anatomía patológica de carcinoma epidermoide. Se le solicita ecografía endoscópica y PET-TAC donde no se observan adenopatías patológicas. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la MÁS correcta?

1. Esofagectomía trashitál.
2. Esofagectomía según la técnica de Ivor-Lewis.
3. Quimioterapia + radioterapia preoperatoria.
4. Quimioterapia neoadyuvante.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Esta pregunta es controvertida, dado que el tratamiento del cáncer de recto depende del estadiaje locorregional tanto de la T (capas afectadas del esófago) como de la N (adenopatías patológicas). Básicamente podríamos resumir que los pacientes con tumores localizados se pueden tratar directamente (endoscópicamente o quirúrgicamente en función de la T) mientras que los tumores localmente avanzados se tratan de inicio con neoadyuvancia. El enunciado de la pregunta omite la información sobre las capas afectadas, especificando únicamente que no tiene adenopatías, lo que nos podría hacer dudar con la opción quirúrgica. Sin embargo, si nos basamos en lo más frecuente, y en la clínica que presenta el paciente (disfagia y lesión estenosante en la endoscopia), la mayoría de los cánceres epidermoides de esófago de tercio medio serán inicialmente tratados con Qt-Rt Neoadyuvante (respuesta 3 correcta)".

-----o-----

Ante un paciente con dolor en hipocondrio derecho, fiebre y leucocitosis, ¿que signo esperaría encontrar usted?

1. Signo de Rovsing
2. Signo de Murphy
3. Signo de Cullen
4. Signo de Coirvoisier - Terrier

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El signo de Blumberg o signo de rebote se puede presentar en cualquier caso de peritonitis al vibrar el peritoneo con la descompresión brusca.

El signo de Murphy es característico de la colecistitis aguda.

Los signos de Rovsing y del psoas son característicos de la apendicitis aguda, este último de la localización retrocecal.

-----o-----

Indique cuál de las siguientes NO es una indicación de cirugía en la pancreatitis aguda grave:

1. Necrosis pancreática infectada.
2. Mala respuesta al tratamiento médico intensivo.
3. Presencia de colecciones pancreáticas.
4. Aumento de la presión intraabdominal: síndrome compartimental.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La presencia de colecciones pancreáticas es indicación de drenaje percutáneo bajo control radiológico. Se intenta demorar el tratamiento quirúrgico lo máximo posible si la estabilidad del paciente lo permite.

-----o-----

El tronco celíaco constituye la primera rama de la aorta intraabdominal. ¿Cuáles son sus tres ramas principales?

1. Arteria hepática común, gástrica derecha y esplénica.
2. Arteria hepática propia, gástrica derecha y esplénica.
3. Arteria hepática propia, gástrica izquierda y gastroepiploica izquierda.
4. Arteria hepática común, gástrica izquierda y esplénica.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil sobre anatomía vascular del área abdominal, que ha sido preguntada previamente en algunas convocatorias de forma directa. El tronco celíaco nace de la arteria aorta a nivel de L1, ramificándose en arteria hepática común, arteria gástrica izquierda y arteria esplénica. La arteria hepática común se divide posteriormente en hepática propia y gastroduodenal (respuesta 4 correcta).

-----o-----

Un paciente con molestias anales y hemorroides de larga evolución, relata que recientemente sus hemorroides han empeorado y ya no se reducen solas y ha de empujarlas después de la higiene, volviendo a exteriorizarse en cada deposición. Son hemorroides grado:

1. 2

- 2. 3
- 3. 4
- 4. Externas

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Recuerda la clasificación de las hemorroides internas:

Grado 1: no prolapsadas

Grado2: Prolapso con el esfuerzo, se reduce espontáneamente.

Grado 3: Prolapso con el esfuerzo, se reduce manualmente.

Grado 4: prolapso irreductible, permanente

-----O-----

Hombre de 70 años de edad, con antecedentes de demencia senil, estreñimiento crónico y abuso de laxantes, que presenta náuseas y dolor abdominal. En la exploración, el abdomen está distendido y doloroso a la palpación, sobre todo en el flanco izquierdo, con percusión timpánica y ruidos "metálicos". En la radiografía de abdomen se aprecia gran distensión del colon, que se incurva produciendo una imagen en "grano de café". El diagnóstico MÁS probable en este paciente es:

- 1. Síndrome de Ogilvie.
- 2. Diverticulitis aguda.
- 3. Vólvulo de ciego.
- 4. Vólvulo de sigma.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La localización más frecuente de vólvulo de colon es a nivel sigmoideo. Clínicamente, se manifiesta por un cuadro de dolor y distensión abdominal. Si se produce necrosis tisular como consecuencia de la isquemia sostenida, habría fiebre, leucocitosis y expulsión de material fecaloideo teñido de sangre. Desde el punto de vista radiológico, es característica una importante distensión del colon, con una imagen en "grano de café" o "en asa de omega". Lógicamente, este cuadro produce una obstrucción intestinal, que se traduce como ruidos metálicos a la auscultación, como otros cuadros obstructivos.

Como tratamiento, inicialmente se intenta una reducción urgente no quirúrgica, mediante colonoscopia, seguida de la colocación posterior de una sonda rectal. Esto es suficiente en un 75% de los casos. El problema es que recidiva con bastante frecuencia, por lo que no es raro tener que recurrir a una cirugía diferida (cirugía urgente en caso de fracaso de colonoscopia, inestabilidad, sepsis o peritonismo).

-----O-----

Ante un paciente ingresado en la planta a nuestro cargo, que comienza con cuadro de dolor torácico, con el antecedente de una endoscopia digestiva alta realizada 12 horas antes, decidimos realizar pruebas de imagen que confirmen el diagnóstico que

sospechamos. Se realizan una Rx de tórax y una TAC torácica, que demuestran la presencia de aire extraluminal, diagnosticando al paciente de una perforación esofágica. Con respecto al tratamiento del paciente, señale la afirmación INCORRECTA:

1. En ausencia de sepsis se puede tratar conservadoramente.
2. Si el paciente presenta fiebre, leucocitosis, taquicardia o mal estado general optaríamos por la opción quirúrgica, consistente en sutura primaria.
3. La mejor opción quirúrgica es la resección con anastomosis.
4. El tratamiento médico implica la disponibilidad de radiólogos intervencionistas, endoscopistas y cirujanos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El tratamiento de los pacientes con perforación esofágica precisa de un equipo multidisciplinar integrado por radiólogos, cirujanos, endoscopistas e intensivistas, ya que se trata de una patología compleja que puede precisar terapéuticas variadas. Si el paciente está estable y sin signos de sepsis, se debe optar por el tratamiento conservador, que implica antibioterapia de amplio espectro y el drenaje de colecciones mediastínicas y pleurales a través de radiología intervencionista. Si el paciente está inestable o séptico, se debe operar: si ha pasado poco tiempo desde la perforación, lo ideal es hacer una sutura primaria, con la colocación de drenajes para detectar y drenar posibles fistulas. Si la perforación lleva más de 24 horas y el paciente está grave, no debemos intentar la anastomosis por los malos resultados de esta (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos) y optaríamos por la exclusión esofágica alimentando al paciente con una sonda de gastrostomía.

-----O-----

Un varón de 65 años acude a su consulta refiriendo notarse una tumoración o bulto en la región lateral izquierda del cuello durante las comidas que aumenta progresivamente de tamaño. Ocasionalmente presenta regurgitación de material maloliente. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y qué pruebas indicaría?

1. Linfoma - ECO cervical.
2. Quiste braquial - ECO cervical.
3. Divertículo de Zenker - Esofagograma (tránsito esofágico).
4. Linfoma - RNM cervical.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El divertículo de Zenker se localiza en la parte posterior de la hipofaringe, por encima del músculo cricofaríngeo y debajo del músculo constrictor inferior de la faringe. Se origina por pulsión/hiperpresión. Puede causar halitosis, regurgitación, disfagia orofaríngea, tos, etc. Como complicaciones puede producir episodios de broncoaspiración, formación de fistulas entre el divertículo y la tráquea, hemorragia intradiverticular y, más raramente, la aparición de un carcinoma epidermoide dentro del divertículo. El tratamiento es quirúrgico, realizando una miotomía cricofaríngea y extirpando el divertículo.

-----O-----

Respecto a los siguientes cuadros clínicos señale la opción falsa:

1. Un paciente con dolor en HCD que se autolimita sin fiebre ni elevación importante de reactantes de fase aguda sugiere tratarse de un cólico biliar cuyo tratamiento es médico con espasmolíticos.
2. Un paciente con dolor mantenido en HCD, Murphy positivo, con fiebre y elevación de reactantes de fase aguda muy probablemente padece una colecistitis aguda.
3. La Triada de Charcot : dolor en hipocondrio derecho + fiebre + ictericia es típica de la colangitis aguda. Si se añade Shock y obnubilación se denomina Pentada de Reynolds. El tratamiento inicial consiste en antibioterapia y eliminar la obstrucción mediante CPRE.
4. Un dolor epigástrico irradiado en cinturón con aumento de amilasa ó lipasa es diagnóstico de pancreatitis aguda y siempre precisa antibioterapia.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La pancreatitis no precisa tratamiento antibiótico si no hay infección demostrada. Se trata con reposo digestivo y analgesia y tratamiento de soporte.

El resto de las respuestas nos dan las claves típicas para diferenciar el cuadro clínico de cólico biliar-colecistitis aguda y colangitis aguda.

Con respecto a las hernias de hiato, señale la afirmación INCORRECTA:

1. La hernia por deslizamiento es la más frecuente.
2. Las hernias tipo I, por lo general, son sintomáticas y requieren tratamiento quirúrgico.
3. La hernia tipo II o paraesofágica presenta herniación del fundus gástrico con la unión gastroesofágica en su sitio.
4. La hernia tipo IV o complejas se debe a la migración intratorácica de cualquier órgano abdominal.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las hernias de hiato tipo I o por deslizamiento son las más frecuentes. La unión gastroesofágica (UGE) se desplaza al mediastino por el hiato. No presentan saco herniario; son, por lo general, asintomáticas; precisan tratamiento únicamente cuando existen criterios quirúrgicos de RGE sintomático (opción 2 incorrecta, por lo que la marcamos). Las hernias paraesofágicas constituyen una auténtica herniación del estómago (generalmente *fundus*) dentro de un saco herniario en el mediastino, debido a la debilidad de la membrana pleuroperitoneal. Son típicas de mujeres mayores. Pueden ser asintomáticas, presentar síntomas típicos de reflujo (pirosis, regurgitación, dolor torácico posprandial y disfagia), o presentar complicaciones debidas al defecto anatómico que producen síntomas compresivos (saciedad temprana y dolor torácico). Deben ser operadas debido al riesgo de vólvulo gástrico, anemia (por úlceras de Cameron, erosiones lineales en los pliegues del estómago herniado) o complicaciones intratorácicas. Se distinguen tres tipos:

- 1) Tipo II o paraesofágicas puras. La UGE permanece en su sitio y el *fundus* se hernia por el hiato.
- 2) Tipo III o mixtas (combinan la tipo I y la tipo II). Son las más comunes de las hernias paraesofágicas.
- 3) Tipo IV o complejas. Se deben a la migración intratorácica de cualquier órgano abdominal (colon, intestino, bazo, etc.).

Con respecto al cáncer de esófago, señale la afirmación CORRECTA:

1. La invasión del árbol traqueobronquial no contraindica la neoadyuvancia.
2. La presencia de afectación ganglionar supraclavicular indica enfermedad diseminada.
3. La positividad en la expresión del biomarcador Her-2 confiere mejor pronóstico.
4. La radioterapia no tiene indicación en estadio avanzado.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Respecto al cáncer de esófago debemos conocer los métodos diagnósticos y las indicaciones en su tratamiento, ya que su grado de afectación va a determinar cuál es la mejor opción terapéutica. Para responder adecuadamente a esta pregunta es importante saber cuáles son los criterios de irresecabilidad del cáncer esofágico y los criterios de enfermedad diseminada. La mayoría de los tumores malignos del esófago se presentan en estadio avanzado al diagnóstico por su capacidad de invasión y de diseminación ganglionar debido a la vascularización linfática del esófago que favorece la dispersión de las células tumorales. Veamos las demás opciones de respuesta:

- 1.- No existe indicación para la neoadyuvancia, aunque sí para el tratamiento paliativo.
- 2.- Los criterios de irresecabilidad del cáncer de esófago incluyen los tumores T4b (invasión grandes vasos, árbol traqueobronquial) y se considera enfermedad diseminada (M1+) la afectación a distancia y las metástasis ganglionares en grupos no regionales como ocurre a nivel supraclavicular o la axilar (respuesta 2 correcta).
- 3.- En pacientes candidatos a quimioterapia se debe estudiar la expresividad del biomarcador Her-2, que es positiva aproximadamente en un 20-25% de los pacientes y que confiere generalmente peor pronóstico, pero aporta una diana terapéutica para el tratamiento con el anticuerpo monoclonal Trastuzumab.
- 4.- Los estadios avanzados pero resecables tienen indicación de tratamiento neoadyuvante mediante quimiorradioterapia y posterior evaluación de cara al tratamiento quirúrgico con intención curativa. Sin embargo, los pacientes con lesiones NO resecables o con enfermedad diseminada a distancia no son candidatos a tratamiento quirúrgico curativo, sino que las medidas van a ser paliativas, entre las que destaca la quimiorradioterapia como tratamiento definitivo y otras medidas destinadas a la paliación sintomática como la colocación de endoprótesis.

-----o-----

Paciente mujer de 65 años que es diagnosticado de adenocarcinoma de antro gástrico. El estudio de extensión mediante ecoendoscopia y TAC revela una tumoración que invade la subserosa con 4 adenopatías locorreionales afectas. No se observan metástasis a distancia. Indique la opción que le parece menos correcta en este caso:

1. Es recomendable una laparoscopia diagnóstica para descartar diseminación peritoneal.
2. En caso de intervención no es necesaria la linfadenectomía.
3. Es necesario administrar quimioterapia adyuvante.
4. Es necesario administrar quimioterapia neoadyuvante.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La cirugía es el tratamiento de elección en los estadios precoces de la enfermedad (T0-1 y algún T2 N0), así como en caso de sintomatología obstructiva o hemorrágica dominante. El resto de pacientes, se benefician de un tratamiento combinado, quimioterapia neoadyuvante, cirugía y quimioterapia adyuvante. Así la paciente del caso presenta una estadificación T3, N2, M0 por lo que se beneficia de esta estrategia terapéutica.

Varón de 67 años que acude a consulta por disfagia progresiva que comenzó para líquidos y posteriormente para sólidos. Su médico solicita una endoscopia digestiva alta en la que se aprecia una estenosis sospechosa de neoplasia en esófago cervical cercana a la unión faringoesofágica. Se le realiza estudio de extensión en el que se aprecia tumoración a dicho nivel que afecta a todas las capas del esófago sin objetivarse diseminación locorregional ni a distancia. El tratamiento MÁS adecuado para este paciente será:

1. Radioquimioterapia como tratamiento definitivo.
2. Radioquimioterapia neoadyuvante y posterior cirugía.
3. Colocación de endoprótesis paliativa.
4. Esofagectomía total con gastroplastia tubular y anastomosis cervical.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Los tumores de esófago cervical no se benefician del tratamiento quirúrgico, por lo que el tratamiento de elección es la radioquimioterapia para todos los estadios. Las prótesis no son útiles en los tumores de esófago cervical, por la dificultad de anclaje y la mala tolerancia por los pacientes a nivel orofaríngeo. En todo caso el tratamiento en este caso no sería paliativo sino radioquimioterapia con intención curativa (respuesta 1 correcta).

Paciente de 29 años, operada por endometriosis (anexectomía izquierda) hace 2 años. Acude a Urgencias presentando un cuadro de dolor abdominal, que se ha ido localizando en fosa ilíaca derecha, náuseas, dos vómitos y febrícula. No refiere diarrea. Está en la mitad del ciclo. En la exploración parece existir más dolor en fosa ilíaca derecha, sin contractura local, pero con signo de Blumberg positivo. En el tacto vaginal parece que hay más dolor al palpar el anexo derecho. Analíticamente presenta 11.000 leucocitos (79% neutrófilos). La Rx de abdomen es normal. ¿Cuál de las siguientes actitudes le parece menos adecuada?

1. Pedir valoración ginecológica.
2. Realizar ecografía abdominal.
3. Dejar en observación 12 horas, y hacer nueva valoración clínica y analítica.
4. Intervenir quirúrgicamente.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En el abdomen agudo, cuando el paciente está estable, es importante completar el diagnóstico diferencial, dado que muchas causas de abdomen agudo no son quirúrgicas.

Por tanto, cuando existen dudas diagnósticas, como en el caso clínico, son oportunas las actitudes conservadoras como las respuestas 1,2 y 3. Si existe duda en el diagnóstico no contemplamos la cirugía directamente salvo inestabilidad clínica.

Un paciente con colelitiasis es intervenido quirúrgicamente. Tras la intervención presenta malestar abdominal, dolor, náuseas, meteorismo..., muy semejantes los síntomas a los que presentaba antes de la cirugía. ¿Cuál es la causa más habitual de estos síntomas postcolecistectomía?:

1. Desorden extrabiliar ya presente antes de la colecistectomía.
2. Coledocolitiasis.
3. Fístula biliar postoperatoria.
4. Síndrome del muñón cístico.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Cuando se interviene a un paciente de colecistectomía y continua teniendo los mismo síntomas tras la operación, hay que descartar siempre que los síntomas no tengan otro origen, pues la causa más frecuente de clínica persistente tras colecistectomía es que exista un trastorno extrabiliar no detectado (esofagitis por reflujo, úlcera péptica, síndrome postgastrectomía, pancreatitis crónica o síndrome del colon irritable). La respuesta correcta, por lo tanto, es la 1.

Una vez descartado esto y el paciente continua con síntomas, entonces se habla de síndrome postcolecistectomía. En conjunto, la colecistectomía es una intervención con una elevada tasa de éxitos. Sin embargo, un reducido grupo de pacientes persistirá con sintomatología debido a una alteración de la vía biliar extrahepática, incluyéndose dentro del llamado síndrome postcolecistectomía.

¿En cuál de las siguientes patologías el estudio radiológico nos va a ser de escasa utilidad para establecer el diagnóstico de un paciente que presentó una hemorragia digestiva alta?:

1. Síndrome de Mallory-Weiss.
2. Cáncer epidermoide de esófago.
3. Linfoma gástrico.
4. Adenocarcinoma de estómago.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El diagnóstico ante una hemorragia digestiva alta debe ser siempre endoscópico. De esta forma puede también, en ocasiones, realizarse una maniobra terapéutica adicional. Sin embargo, en ocasiones el estudio radiológico baritado sirve de apoyo para identificar un proceso determinado o sus complicaciones. En el síndrome de Mallory- Weiss consiste en una hemorragia digestiva alta que se produce como consecuencia de erosiones longitudinales en la región de la unión gastroesofágica. Habitualmente se produce tras intensos vómitos o incluso tos. Es más frecuente en personas alcohólicas. En este síndrome no se observan lesiones radiológicas relevantes.

Un paciente presenta un cuadro de dolor abdominal agudo con signos de irritación

peritoneal difusos. Está taquicárdico, sudoroso, hipotenso e impresiona de gravedad. Su actitud será:

1. Laparotomía urgente
2. TAC
3. ECO
4. Arteriografía urgente

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Ante un paciente con abdomen agudo debemos plantearnos si el paciente está estable o inestable, si está grave o no lo está.

Si un paciente está estable, sin datos de gravedad clínica, debemos investigar la causa y hacer el diagnóstico diferencial. Pero si está grave debemos proceder a la cirugía urgente.

-----o-----

Señale cuál de las siguientes lesiones premalignas NO es un factor de riesgo de carcinoma epidermoide de esófago:

1. Acalasia.
2. Esofagitis cáustica.
3. Divertículo esofágico.
4. Esófago de Barrett.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Las lesiones premalignas consideradas factor de riesgo de cáncer epidermoide son:

- Acalasia.
- Esofagitis cáustica.
- Divertículos esofágicos.

El esófago de Barrett es factor de riesgo para el adenocarcinoma de esófago (marcamos la opción de respuesta 4).

-----o-----

De las siguientes técnicas quirúrgicas, indique en la que NO es esperable, de entrada, la realización de un estoma:

1. Panproctocolectomía restauradora con reservorio ileoanal.
2. Amputación abdominoperineal.
3. Bypass gástrico laparoscópico.
4. Intervención de Hartmann.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Debemos realizar estomas ante tres situaciones fundamentalmente:

- De forma temporal para proteger anastomosis de riesgo como sucede en las anastomosis colo o ileoanales (panproctocolectomía restauradora con reservorio ileoanal) o colorrectales muy bajas (resección anterior baja con escisión mesorrectal total). Generalmente usamos ileostomías “de descarga” que se cerrarán tras seis semanas de la Cirugía inicial, si no ha habido complicaciones de la misma. Algunos centros prefieren no hacerlas en la Cirugía inicial y la reservan para tratar la complicación (la dehiscencia de la anastomosis), pero es un aspecto controvertido.
- En pacientes donde no se puede reestablecer el tránsito, bien porque no tengan una buena continencia o porque exista un tumor que afecte a los esfínteres: amputación abdominoperineal.
- Situaciones de urgencia que impidan la realización de una anastomosis, bien porque haya “que correr” y no se pueda emplear tiempo en hacer una anastomosis (control de daños), o bien porque exista alto riesgo de fracaso de la misma por sepsis local o difusa, desnutrición, terapias con corticoides, etc., en el caso de la intervención de Hartmann por perforaciones de colon izquierdo y sepsis que contraindique la anastomosis primaria.

Las intervenciones gástricas e intestinales rara vez requieren el uso de un estoma, al menos de entrada (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

-----o-----

Paciente varón de 86 años con cardiopatía isquémica que requirió revascularización mediante triple bypass coronario. Actualmente sigue tratamiento con clopidogrel y tratamiento antihipertensivo que no recuerda. Exfumador desde hace 5 años, presenta EPOC severa que controla con inhaladores de budesonida y salbutamol. Acude a consulta por presentar aumento del número de deposiciones con mucosidad abundante y manchado de la ropa interior. En el tacto rectal no se palpa nada, aunque el dedo sale manchado de moco y sangre. La colonoscopia describe la presencia de un pólipo en cara posterior del recto medio, a unos 9 cm de margen anal, de unos 3 cm de diámetro y amplia base, irresecable endoscópicamente, por lo que lo biopsian. Biopsia: adenoma vellosa con displasia severa – carcinoma in situ. La actitud terapéutica más adecuada en este paciente será:

1. Amputación abdominoperineal dado que presenta incontinencia.
2. Escisión mesorrectal total laparoscópica y anastomosis colorectal baja, dado que la incontinencia puede ser secundaria al tumor.
3. Resección local endoscópica transanal (TEM).
4. Quimiorradioterapia neoadyuvante, y si presenta buena respuesta, realizar seguimiento únicamente dado el riesgo quirúrgico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los tumores de recto localizados, hasta T1 N0, son candidatos a resección local de pared completa mediante microcirugía endoscópica transanal (TEM).

Este tratamiento es menos agresivo y por tanto estará especialmente indicado en pacientes ancianos de alto riesgo quirúrgico.

-----o-----

Los tumores benignos MÁS frecuentes del esófago son:

1. Los pólipos fibrovasculares.
2. Los leiomiomas.
3. Los papilomas escamosos.
4. Los hemangiomas.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En el esófago los tumores benignos son menos frecuentes que los malignos. En este caso se trata de una pregunta directa que se debe reconocer ya que se especifica de forma explícita en el manual CTO, Los tumores benignos más frecuentes del esófago son los leiomiomas (respuesta 2 correcta), derivan de la muscular propia del esófago y típicamente aparecen en esófago medio y distal. Se diagnostican mediante ecoendoscopia, precisando tratamiento cuando crecen y causan síntomas. Las demás opciones de respuesta son menos frecuentes:

- 1.- Los pólipos fibrovasculares son tumores de partes blandas, generalmente pediculados, que se sitúan en el esófago proximal pudiendo obstruir la vía aérea.
- 3.- Los papilomas escamosos se asocian a inflamación y aparecen en el esófago distal.
- 4.- Los hemangiomas suelen ser lesiones rojizas submucosas que pueden sangrar.

-----O-----

Hombre de 36 años remitido a la consulta de Cirugía tras drenaje urgente de absceso perianal dos meses antes, persistiendo supuración. El paciente estaba siendo estudiado previamente por digestivo por cuadro de diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso. Colonoscopia: Recto de aspecto normal; a nivel de colon descendente y sigma se alternan zonas con aspecto de “empedrado” y úlceras lineales y profundas con otras de aspecto normal. Se completa estudio con Eco endoanal y RM observándose una fístula transesfinteriana alta. Sin tratamiento médico actual. ¿Cuál sería el tratamiento inicial más adecuado de la fístula?

1. Fistulotomía.
2. Colocación de sedal no cortante en el trayecto de la fístula asociado a tratamiento con metronidazol, infliximab e inmunosupresores.
3. Realizar drenajes repetidos cada vez que presente un absceso, asociando tratamiento con infliximab e inmunosupresores.
4. Esfinterotomía lateral interna.

Resp. Correcta: 2

Comentario: En esta pregunta nos piden contestar cómo debemos actuar quirúrgicamente ante una enfermedad perianal en el contexto de una Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Nos describen un paciente joven en estudio por diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso con una descripción endoscópica sugestiva de enfermedad inflamatoria intestinal (mucosa en empedrado y úlceras lineales y profundas). Además el paciente tiene una fístula compleja (transesfinteriana alta) y episodios previos de absceso perianal. El papel de la cirugía en estos casos es el de drenar la sepsis perianal exclusivamente. Es decir, drenar las cavidades abscesuales y mantener el drenaje permeable mediante la colocación de sedales (setones) para evitar nuevos abscesos. No olvidemos que el tratamiento de la enfermedad perianal de Crohn es el tratamiento médico sistémico, mediante metronidazol inicialmente y posteriormente inmunosupresores o antiTNF como el infliximab (respuesta 2). Dado que el paciente va a estar inmunosuprimido, es prioritario evitar nuevos episodios de abscesos por lo que en ocasiones se mantiene el sedal a largo plazo (hasta conseguir remisión)

o incluso de por vida.

-----O-----

Tras una esofagectomía por una neoplasia esofágica resecable de tercio medio, señale cuál considera el órgano de elección para realizar la plastia para la reconstrucción del tránsito:

1. Colon derecho.
2. Colon descendente.
3. Estómago.
4. Yeyuno.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Para la reconstrucción del tránsito tras una esofagectomía, se considera de primera elección la plastia gástrica. El colon debe utilizarse como alternativa en caso de cirugía o patología gástrica previa, o cuando se lesiona o se devasculariza la plastia durante la cirugía . Por ello es aconsejable siempre el estudio tanto del estómago como del colon antes de la cirugía esofágica.

-----O-----

Un tumor de colon que afecta a la capa muscular se denomina:

1. Tx
2. T1
3. T2
4. T3

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Es importante que recuerdes el TNM del cáncer colorrectal:

Tis: sólo mucosa

T1 afectación submucosa

T2 llega a la muscular

T3 afecta a la subserosa en el colon y a la grasa de mesorrecto en el recto.

T4 afecta a órganos vecinos. Los tumores perforados se consideran T4

-----O-----

Un paciente de 50 años sin antecedentes patológicos presenta disfagia, regurgitación, pirosis y dolor torácico. Es estudiado por sospecha de trastorno motor esofágico y es diagnosticado de acalasia. El tratamiento que usted le aconsejaría sería:

1. Miotomía de Heller.

2. Miotomía endoscópica por vía oral.
3. Inyección de toxina botulínica.
4. Dilatación neumática.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Tratamiento quirúrgico. Es el de elección si existe riesgo quirúrgico aceptable.

- Ventajas: solución definitiva a largo plazo.

- Inconvenientes: más invasiva (inconveniente que ha disminuido con el abordaje laparoscópico). Es menor el riesgo asociado a la miotomía laparoscópica de Heller (MLH) que el que se asocia a dilataciones repetidas.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes es una complicación postquirúrgica que aparece con mayor frecuencia en la laparoscopia que en la cirugía abierta?

1. Trombosis venosa profunda.
2. Eventración (hernia incisional).
3. Dolor postoperatorio.
4. Infección de herida quirúrgica.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Dentro de las principales complicaciones de la cirugía laparoscópica tenemos las lesiones vasculares e intestinales y menos frecuentes lesiones vesicales, uretrales, hernias, infecciones e incluso el cambio de laparoscopia a laparatomía.

-----O-----